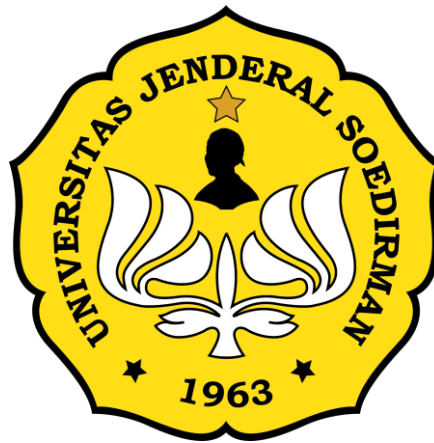


**LAPORAN PROJEK
SISTEM PAKAR**

**“SISTEM PAKAR DIAGNOSA TINGKAT KECANDUAN MEDIA SOSIAL
MENGUNAKAN METODE BACKWARD CHAINING”**



Disusun oleh :

Anindya Diva Talitha	H1D022026
Solani	H1D022033
Mutia Nandhika	H1D022078
Adila Zahira Hasyati	H1D022081
Andhika Putra Restu Ilahi	H1D023089

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURBALINGGA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	3
1.5 Representasi Pengetahuan	3
1.6 Metode yang Digunakan	4
BAB II BASIS PENGETAHUAN DAN INFERENSI.....	6
2.1 Tingkat Kecanduan (Hipotesis)	6
2.2 Gejala Kecanduan (Fakta)	6
2.3 Aturan Produksi (Rule Base)	9
2.4 Pohon Keputusan	10
2.5 Tabel Keputusan	10
2.6 Solusi dan Rekomendasi	12
BAB III PERANCANGAN SISTEM	15
3.1 Use Case Diagram	15
3.2 Sequence Diagram	16
3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)	18
3.4 Struktur Tabel Database	19
IV IMPLEMENTASI SISTEM	20
4.1 Rancangan Wireframe Antarmuka	20
4.2 Implementasi Website Sistem Pakar	37
4.2.1 Halaman Registrasi	38

4.2.2	Halaman Login untuk Autentikasi Pengguna (Admin, User, dan Pakar)	39
4.2.3	Halaman Beranda.....	39
4.2.4	Halaman Awal Diagnosa	40
4.2.5	Halaman Profil	41
4.2.6	Halaman Pertanyaan Tingkat Tidak Kecanduan.....	41
4.2.7	Halaman Pertanyaan Tingkat Mulai Berisiko.....	42
4.2.8	Halaman Pertanyaan Tingkat Kecanduan Ringan	42
4.2.9	Halaman Pertanyaan Tingkat Kecanduan Sedang	43
4.2.10	Halaman Pertanyaan Tingkat Kecanduan Berat	43
4.2.11	Halaman Hasil Diagnosa Tidak Kecanduan	44
4.2.12	Halaman Hasil Diagnosa Mulai Berisiko	44
4.2.13	Halaman Hasil Diagnosa Kecanduan Ringan	45
4.2.14	Halaman Hasil Diagnosa Kecanduan Sedang.....	46
4.2.15	Halaman Hasil Diagnosa Kecanduan Berat.....	46
4.2.16	Halaman Hasil Diagnosa Tidak Termasuk “Tidak Kecanduan”	47
4.2.17	Halaman Hasil Diagnosa Tidak Dapat Didefinisikan.....	47
4.2.18	Halaman Beranda Admin.....	48
4.2.19	Halaman Profil Admin.....	48
4.2.20	Halaman Data Diagnosa Admin	49
4.2.21	Halaman Data Gejala	50
4.2.22	Halaman Data Pertanyaan.....	52
4.2.23	Halaman Data Solusi.....	53
4.2.24	Halaman Data Hasil Diagnosa	54
4.2.25	Halaman Data Hasil Gejala.....	55
4.2.26	Halaman Data Pengguna.....	56
4.2.27	Halaman Tambah Diagnosa.....	57
4.2.28	Halaman Tambah Gejala.....	58

4.2.29	Halaman Tambah Solusi	59
4.2.30	Halaman Tambah Pertanyaan	60
4.2.31	Halaman Tambah Pengguna	61
4.2.32	Halaman Edit Diagnosa	62
4.2.33	Halaman Edit Gejala	63
4.2.34	Halaman Edit Solusi	64
4.2.35	Halaman Edit Pertanyaan.....	65
4.2.36	Halaman Edit Pengguna.....	66
4.2.37	Halaman Beranda Pakar.....	67
4.2.38	Halaman Profil Pakar	68
4.2.39	Halaman Verifikasi Data Diagnosa	68
4.2.40	Halaman Verifikasi Data Gejala	69
4.2.41	Halaman Verifikasi Data Solusi.....	70
4.2.42	Halaman Verifikasi Data Pertanyaan.....	71
4.2.43	Halaman Manejemen Data Aturan Diagnosa	72
BAB V PENUTUP.....		74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Saran	74
LAMPIRAN		77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Kecanduan	6
Tabel 2. Tabel Gejala dan Pertanyaan	7
Tabel 3. Tabel Aturan Gejala.....	9
Tabel 4. Tabel Keputusan	11
Tabel 5. Tabel Solusi	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pohon Keputusan Diagnosa Kecanduan Media Sosial	10
Gambar 2. Use Case Diagram.....	16
Gambar 3. Sequence Diagram untuk User.....	17
Gambar 4. Sequence Diagram untuk Admin	17
Gambar 5. Sequence Diagram untuk Pakar	18
Gambar 6. Entity Relationship Diagram.....	19
Gambar 7. Tabel Database Sistem Pakar Kecanduan Media Sosial	19
Gambar 8. Perancangan Halaman Registrasi.....	20
Gambar 9. Perancangan Halaman Login	21
Gambar 10. Perancangan Halaman Beranda User	21
Gambar 11. Perancangan Halaman Diagnosa User	22
Gambar 12. Perancangan Halaman Pertanyaan	22
Gambar 13. Perancangan Halaman Hasil Diagnosa	23
Gambar 14. Perancangan Halaman Lanjutkan Tes.....	23
Gambar 15. Perancangan Halaman Identifikasi Gagal	24
Gambar 16. Perancangan Halaman Profil User	24
Gambar 17. Perancangan Halaman Beranda Admin	25
Gambar 18. Perancangan Halaman Data Diagnosa	25
Gambar 19. Perancangan Halaman Tambah Diagnosa.....	26
Gambar 20. Perancangan Halaman Edit Diagnosa	26
Gambar 21. Perancangan Halaman Data Gejala.....	27
Gambar 22. Perancangan Halaman Tambah Gejala	27
Gambar 23. Perancangan Halaman Edit Gejala.....	28
Gambar 24. Perancangan Halaman Data Solusi	28
Gambar 25. Perancangan Halaman Tambah Solusi.....	29
Gambar 26. Perancangan Halaman Edit Solusi	29
Gambar 27. Perancangan Halaman Data Pertanyaan	30
Gambar 28. Perancangan Halaman Tambah Pertanyaan.....	30
Gambar 29. Perancangan Halaman Edit Pertanyaan	31
Gambar 30. Perancangan Halaman Data Pengguna	31
Gambar 31. Perancangan Halaman Tambah Pengguna.....	32

Gambar 32. Perancangan Halaman Edit Pengguna	32
Gambar 33. Perancangan Halaman Data Hasil Diagnosa.....	33
Gambar 34. Perancangan Halaman Data Hasil Gejala	33
Gambar 35. Perancangan Halaman Profil Admin.....	34
Gambar 36. Perancangan Halaman Beranda Pakar	34
Gambar 37. Perancangan Halaman Profil Pakar.....	35
Gambar 38. Perancangan Halaman Verifikasi Diagnosa.....	35
Gambar 39. Perancangan Halaman Verifikasi Gejala	36
Gambar 40. Perancangan Halaman Verifikasi Solusi.....	36
Gambar 41. Perancangan Halaman Verifikasi Pertanyaan	37
Gambar 42. Perancangan Halaman Verifikasi Aturan.....	37
Gambar 43. Halaman Registrasi	38
Gambar 44. Pop Up Registrasi Berhasil	39
Gambar 45. Halaman Login.....	39
Gambar 46. Halaman Beranda User	40
Gambar 47. Halaman Awal Diagnosa	40
Gambar 48. Halaman Profil User.....	41
Gambar 49. Halaman Pertanyaan Tingkat Tidak Kecanduan.....	41
Gambar 50. Halaman Pertanyaan Tingkat Mulai Berisiko.....	42
Gambar 51. Halaman Pertanyaan Tingkat Kecanduan Ringan	42
Gambar 52. Halaman Pertanyaan Tingkat Kecanduan Sedang	43
Gambar 53. Halaman Pertanyaan Tingkat Kecanduan Berat	44
Gambar 54. Halaman Hasil Diagnosa Tidak Kecanduan	44
Gambar 55. Halaman Hasil Diagnosa Mulai Berisiko.....	45
Gambar 56. Halaman Hasil Diagnosa Kecanduan Ringan	45
Gambar 57. Halaman Hasil Diagnosa Kecanduan Sedang.....	46
Gambar 58. Halaman Hasil Diagnosa Kecanduan Berat	47
Gambar 59. Halaman Hasil Diagnosa Tidak Termasuk “Tidak Kecanduan”	47
Gambar 60. Halaman Hasil Diagnosa Tidak Dapat Didefinisikan	48
Gambar 61. Halaman Beranda Admin.....	48
Gambar 62. Halaman Profil Admin	49
Gambar 63. Halaman Data Diagnosa Admin	49
Gambar 64. Pop Up Hapus Data Diagnosa pada Admin	50
Gambar 65. <i>Pop Up</i> Data Berhasil Dihapus	50

Gambar 66. Halaman Data Gejala pada Admin.....	51
Gambar 67. Pop Up Hapus Data Gejala pada Admin.....	51
Gambar 68. Pop Up Data Gejala Berhasil Dihapus.....	51
Gambar 69. Data Pertanyaan pada Admin.....	52
Gambar 70. Pop Up Hapus Data Pertanyaan pada Admin	52
Gambar 71. Pop Up Data Pertanyaan Berhasil Dihapus.....	53
Gambar 72. Data Solusi pada Admin	53
Gambar 73. Pop Up Hapus Data Solusi pada Admin	54
Gambar 74. Pop Up Data Solusi Berhasil Dihapus	54
Gambar 75. Data Hasil Diagnosa.....	55
Gambar 76. Pop Up Hapus Data Hasil Diagnosa pada Admin	55
Gambar 77. Pop Up Data Hasil Diagnosa Berhasil Dihapus.....	55
Gambar 78. Data Hasil Gejala	56
Gambar 79. Data Pengguna pada Admin.....	56
Gambar 80. Pop Up Hapus Data Pengguna pada Admin	57
Gambar 81. Pop Up Data Pengguna Berhasil Dihapus.....	57
Gambar 82. Halaman Tambah Diagnosa	58
Gambar 83. Pop Up Data Diagnosa Berhasil Ditambahkan	58
Gambar 84. Halaman Tambah Gejala.....	59
Gambar 85. Pop Up Data Gejala Berhasil Ditambahkan.....	59
Gambar 86. Halaman Tambah Solusi	60
Gambar 87. Pop Up Data Solusi Berhasil Ditambahkan	60
Gambar 88. Halaman Tambah Pertanyaan	61
Gambar 89. Pop Up Data Pertanyaan Berhasil Ditambahkan	61
Gambar 90. Halaman Tambah Pengguna	62
Gambar 91. Pop Up Data Pengguna Berhasil Ditambahkan	62
Gambar 92. Halaman Edit Diagnosa	63
Gambar 93. Pop Up Data Diagnosa Berhasil Diedit.....	63
Gambar 94. Halaman Edit Gejala	64
Gambar 95. Pop Up Data Gejala Berhasil Diedit	64
Gambar 96. Halaman Edit Solusi.....	65
Gambar 97. Pop Up Data Solusi Berhasil Diedit.....	65
Gambar 98. Halaman Edit Pertanyaan.....	66
Gambar 99. Pop Up Data Pertanyaan Berhasil Diedit.....	66

Gambar 100. Halaman Edit Pengguna.....	67
Gambar 101. Pop Up Data Pengguna Berhasil Diedit.....	67
Gambar 102. Halaman Beranda Pakar.....	68
Gambar 103. Halaman Profil Pakar	68
Gambar 104. Halaman Verifikasi Data Diagnosa.....	69
Gambar 105. Pop up Verifikasi Data Diagnosa.....	69
Gambar 106. Halaman Verifikasi Data Gejala	70
Gambar 107. Pop up Verifikasi Data Gejala	70
Gambar 108. Halaman Verifikasi Data Solusi.....	71
Gambar 109. Pop Up Verifikasi Data Solusi	71
Gambar 110. Halaman Verifikasi Data Pertanyaan.....	72
Gambar 111. Halaman Verifikasi Data Pertanyaan.....	72
Gambar 112. Halaman Manajemen Data Aturan.....	73
Gambar 113. Halaman Data Aturan Tiap Diagnosa	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, salah satunya melalui munculnya media sosial. *Platform* seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan X kini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseharian kita. Melalui media sosial, individu bisa berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri dengan mudah dan cepat. Seperti yang diungkapkan Kuss dan Griffiths (2017), penggunaan media sosial sudah menjadi aktivitas rekreasi penting bagi banyak orang, memungkinkan mereka untuk terhubung tanpa batasan waktu dan ruang.

Namun, kebutuhan untuk selalu terhubung secara daring ini telah menjadi perhatian para peneliti, karena dapat menyebabkan penggunaan media sosial yang kompulsif. Dalam kasus ekstrim, hal ini dapat menimbulkan gejala dan konsekuensi yang mirip dengan kecanduan zat adiktif, seperti hilangnya kontrol, munculnya rasa cemas saat tidak terhubung, serta pengabaian tanggung jawab sehari-hari (Kuss & Griffiths, 2017). Fenomena kecanduan media sosial juga terjadi di Indonesia, di mana pengguna media sosial terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data We Are Social dan Hootsuite pada Januari 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta orang atau sekitar 56% dari total populasi, dan angka ini terus bertambah setiap tahun (Wiyono et al., 2022).

Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah sistem pakar. Sistem pakar merupakan bagian dari kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang meniru kemampuan seorang ahli dalam pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Dengan menggunakan metode Backward Chaining, sistem pakar dapat menganalisis dari hipotesis akhir menuju fakta-fakta (gejala) yang mendukungnya secara efisien. Metode ini memungkinkan proses inferensi yang terstruktur dan sistematis, sehingga cocok digunakan dalam sistem diagnosis (Dewi, Anraeni, & Manga, 2023). Penggunaan sistem pakar untuk mendiagnosis tingkat kecanduan media sosial juga telah terbukti efektif, seperti yang ditunjukkan oleh Ariani et al. (2023), bahwa sistem pakar dapat memberikan diagnosis tingkat kecanduan, persentase keyakinan, serta informasi dampak dan solusi untuk mengurangi kecanduan

media sosial, sehingga dapat menjadi alternatif konsultasi yang lebih mudah dan efisien dibandingkan konsultasi langsung ke klinik psikologi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan masyarakat dapat mengenali potensi kecanduan media sosial sejak dini dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat sebelum dampaknya semakin merugikan kesehatan mental dan sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Sistem pakar adalah program kecerdasan buatan yang menggabungkan basis pengetahuan dengan sistem inferensi untuk meniru cara berpikir seorang ahli dalam memecahkan masalah. *Backward Chaining* adalah strategi penarikan kesimpulan yang dimulai dari hipotesis atau kesimpulan terlebih dahulu, kemudian ditelusuri ke belakang untuk menemukan fakta-fakta atau gejala yang mendukungnya. Pendekatan ini sangat cocok untuk sistem diagnosis, karena memungkinkan sistem untuk menyelidiki apakah gejala-gejala tertentu mendukung kesimpulan yang telah ditentukan. Sistem ini juga dapat dikembangkan dengan pemantauan digital serta terhubung ke internet untuk mendukung akurasi dan integrasi informasi.

Berdasarkan latar belakang dan pendekatan tersebut, maka rumusan masalahnya dapat mencakup:

- a. Bagaimana merancang sistem pakar yang dapat mendiagnosis tingkat kecanduan media sosial berdasarkan gejala yang dialami pengguna?
- b. Bagaimana metode *Backward Chaining* dapat diterapkan dalam sistem pakar untuk mendiagnosis kecanduan media sosial?
- c. Sejauh mana sistem pakar yang dibangun dapat memberikan diagnosis yang akurat dan membantu pengguna dalam mengenali tingkat kecanduan media sosial?

1.3 Tujuan

Penelitian ini hadir untuk menyediakan alat yang objektif dalam menilai tingkat kecanduan media sosial. Dengan metode *Backward Chaining*, sistem akan memulai dari hipotesis tingkat kecanduan dan menelusuri gejala-gejala spesifik yang muncul. Hasil diagnosis dirancang agar mudah dipahami pengguna dan disertai rekomendasi tindak lanjut yang jelas.

- a. Merancang dan mengembangkan sistem pakar untuk mendiagnosis tingkat kecanduan media sosial.
- b. Menerapkan metode *Backward Chaining* dalam sistem pakar untuk menganalisis gejala dan menentukan tingkat kecanduan.
- c. Membantu pengguna dalam mengenali dan memahami tingkat kecanduan media sosial yang dialami, serta memberikan rekomendasi untuk langkah selanjutnya.

1.4 Manfaat

Sistem pakar ini hadir dengan sejumlah manfaat praktis yang dapat langsung dirasakan oleh pengguna. Dengan semakin banyaknya individu yang terhubung dengan media sosial, penting untuk meningkatkan kesadaran akan potensi kecanduan yang bisa terjadi. Melalui sistem ini, pengguna dapat lebih mudah mengenali tanda-tanda kecanduan sejak dini, sebelum dampaknya menjadi lebih parah.

- a. Sistem ini membantu individu untuk lebih sadar terhadap kebiasaan penggunaan media sosial mereka, sehingga dapat mengenali tanda-tanda kecanduan sejak dini sebelum dampaknya menjadi lebih serius.
- b. Pengguna dapat mendiagnosis kondisi mereka tanpa harus langsung berkonsultasi dengan psikolog atau ahli, yang bisa jadi memakan biaya atau waktu.
- c. Sistem memberikan rekomendasi berdasarkan gejala yang dialami pengguna, sehingga bisa dijadikan pertimbangan awal dalam mengambil langkah seperti mengurangi waktu penggunaan atau mencari bantuan profesional.

1.5 Representasi Pengetahuan

Kecanduan media sosial merupakan kondisi psikologis yang ditandai dengan dorongan yang sulit dikendalikan untuk menggunakan platform media sosial secara berlebihan. Fenomena ini semakin meningkat seiring dengan tingginya penetrasi internet dan kemudahan akses melalui perangkat mobile. Kecanduan ini dapat menyebabkan dampak negatif seperti menurunnya produktivitas, gangguan tidur, penurunan kualitas hubungan sosial, hingga gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Untuk mendiagnosa tingkat kecanduan, diperlukan pendekatan sistematis berbasis gejala-gejala seperti frekuensi penggunaan, perasaan gelisah saat tidak

mengakses media sosial, dan ketidakmampuan mengurangi waktu penggunaan. Dengan pendekatan *backward chaining*, sistem pakar akan menelusuri gejala-gejala tersebut dari hipotesis tingkat kecanduan tertentu untuk menentukan kesimpulan secara logis dan terstruktur.

1.6 Metode yang Digunakan

Backward Chaining merupakan salah satu metode penalaran dalam sistem pakar yang berorientasi pada tujuan (*goal-driven reasoning*), di mana proses inferensi dimulai dari kesimpulan atau hipotesis yang ingin dibuktikan, kemudian ditelusuri ke belakang untuk menemukan fakta-fakta atau gejala yang mendukung kesimpulan tersebut. Dalam sistem pakar, metode ini bekerja dengan menelusuri aturan-aturan dalam basis pengetahuan yang memiliki kesimpulan sesuai dengan hipotesis, lalu memeriksa apakah semua premis atau kondisi dalam aturan tersebut terpenuhi oleh data atau fakta yang dimasukkan oleh pengguna. Jika semua kondisi terpenuhi, maka sistem menyatakan hipotesis tersebut benar. Sebagaimana dijelaskan oleh Wulandari dan Nugroho (2021), *Backward Chaining* merupakan metode yang efektif dalam sistem pakar untuk melakukan diagnosis berdasarkan gejala yang ada, karena memungkinkan proses inferensi yang terstruktur dan sistematis. Selain itu, Fitriani (2020) menambahkan bahwa sistem pakar bekerja dengan mencocokkan gejala yang diinputkan pengguna dengan aturan-aturan yang telah disusun berdasarkan pengetahuan pakar, sehingga diagnosis dapat diberikan secara cepat dan akurat. Metode ini menghemat waktu dan upaya dalam mencapai keputusan akhir dengan menyesuaikan solusi berdasarkan informasi yang ditemukan selama proses penelusuran mundur (Huda et al., 2023). Dalam penelitian ini, metode *backward chaining* diterapkan untuk merancang sistem pakar yang dapat mendiagnosis tingkat kecanduan media sosial berdasarkan gejala yang dialami pengguna. Misalnya, ketika sistem ingin membuktikan apakah seseorang mengalami kecanduan berat, maka sistem akan mencari aturan dengan kesimpulan tersebut dan menelusuri apakah gejala seperti penggunaan media sosial secara berlebihan, rasa cemas saat tidak online, dan kesulitan mengontrol durasi penggunaan terpenuhi. Jika semua gejala ini sesuai dengan yang terdapat dalam aturan, maka sistem akan memberikan diagnosis dan rekomendasi yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan ini, proses diagnosis menjadi lebih

terstruktur, efisien, dan menyerupai cara kerja seorang ahli dalam menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang tersedia.

BAB II

BASIS PENGETAHUAN DAN INFERENSI

2.1 Tingkat Kecanduan (Hipotesis)

Tingkat kecanduan merupakan hasil akhir yang akan dihasilkan oleh sistem pakar berdasarkan gejala-gejala yang dipilih oleh pengguna. Dalam konteks diagnosis kecanduan media sosial, tingkat kecanduan dikategorikan menjadi lima kelas utama, mulai dari kondisi yang sehat hingga tingkat kecanduan yang parah. Klasifikasi ini digunakan sebagai hipotesis utama dalam metode inferensi *Backward Chaining*, di mana sistem akan menelusuri gejala-gejala yang mendukung masing-masing hipotesis. Klasifikasi tingkat kecanduan media sosial ditunjukkan seperti pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tingkat Kecanduan

Kode	Tingkat Kecanduan
TK01	Tidak Kecanduan
TK02	Mulai Berisiko
TK03	Kecanduan Ringan
TK04	Kecanduan Sedang
TK05	Kecanduan Berat

Masing-masing kategori ini akan digunakan sebagai simpulan dari proses diagnosis sistem pakar. Jika sejumlah gejala terpenuhi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam basis pengetahuan, maka sistem akan menampilkan salah satu dari lima tingkat kecanduan tersebut beserta rekomendasi solusi yang sesuai. Pendekatan ini memungkinkan sistem memberikan hasil diagnosis yang sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara logika inferensi.

2.2 Gejala Kecanduan (Fakta)

Gejala merupakan fakta-fakta atau indikasi awal yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam sistem pakar. Dalam konteks diagnosis kecanduan media sosial, gejala ini mencerminkan perilaku, perasaan, atau kebiasaan pengguna saat berinteraksi dengan media sosial. Setiap gejala direpresentasikan dengan sebuah kode unik (G01–G20) dan dikaitkan dengan satu pertanyaan yang akan dijawab oleh pengguna sistem. Jawaban terhadap pertanyaan ini akan menentukan apakah gejala

tersebut muncul atau tidak, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam proses inferensi. Daftar gejala kecanduan beserta pertanyaan yang sesuai untuk membantu proses diagnosis ditunjukkan seperti pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Tabel Gejala dan Pertanyaan

Kode	Gejala	Pertanyaan
G01	Menggunakan media sosial hanya saat senggang	Menggunakan media sosial hanya saat waktu senggang?
G02	Tidak merasa gelisah saat tidak membuka media sosial	Tidak merasa gelisah saat tidak membuka media sosial?
G03	Tidak merasa harus selalu <i>update</i> tentang aktivitas orang lain	Tidak merasa harus tahu semua aktivitas orang lain di media sosial?
G04	Bisa berhenti menggunakan media sosial kapan saja	Bisa berhenti menggunakan media sosial kapan pun?
G05	Sering membuka media sosial tanpa tujuan jelas	Sering membuka media sosial tanpa alasan jelas?
G06	Merasa perlu mengecek media sosial saat bangun tidur	Langsung mengecek media sosial begitu bangun tidur?
G07	Sering mengecek notifikasi meski tidak penting	Sering mengecek notifikasi meski tidak penting?
G08	Merasa kurang <i>update</i> jika tidak membuka media sosial	Merasa kurang <i>update</i> jika tidak membuka media sosial dalam sehari?
G09	Menggunakan media sosial untuk menghindari masalah pribadi	Menggunakan media sosial untuk menghindari masalah pribadi?
G10	Sering membuka media sosial saat sedang bersama keluarga/teman	Membuka media sosial saat sedang berkumpul dengan keluarga/teman?
G11	Merasa senang jika mendapat banyak <i>likes</i> atau komentar	Merasa senang jika mendapat banyak <i>like</i> /komentar?

G12	Gagal mengurangi waktu <i>online</i> meski sudah mencoba	Gagal mengurangi waktu <i>online</i> meskipun sudah mencoba?
G13	Mengabaikan pekerjaan atau tugas karena media sosial	Mengabaikan pekerjaan atau tugas penting karena sibuk di media sosial?
G14	Sering merasa kesal jika dilarang membuka media sosial	Sering marah/kesal saat dilarang membuka media sosial?
G15	Sulit fokus belajar atau bekerja karena keinginan membuka media sosial	Sulit fokus belajar/kerja karena ingin membuka media sosial?
G16	Merasa lebih nyaman di media sosial dibanding dunia nyata	Merasa lebih nyaman hidup di media sosial daripada dunia nyata?
G17	Menggunakan media sosial hingga larut malam hampir setiap hari	Sering menggunakan media sosial hingga larut malam setiap hari?
G18	Merasa cemas berlebihan jika tidak bisa mengakses media sosial	Merasa sangat cemas jika tidak bisa mengakses media sosial?
G19	Mengalami konflik serius dengan orang terdekat karena media sosial	Sering berkonflik dengan orang terdekat karena penggunaan media sosial?
G20	Lebih banyak waktu di dunia maya daripada interaksi langsung	Lebih banyak waktu online daripada berinteraksi langsung di dunia nyata?

Gejala-gejala ini dirancang untuk mencakup aspek frekuensi penggunaan, pengaruh emosional, dampak sosial, serta gangguan pada aktivitas sehari-hari, sehingga sistem dapat menangkap gambaran kondisi psikologis pengguna secara menyeluruh.

2.3 Aturan Produksi (*Rule Base*)

Aturan produksi merupakan inti dari sistem inferensi dalam sistem pakar. Aturan ini berbentuk logika IF–THEN, yang menyatakan bahwa jika sejumlah gejala tertentu terpenuhi, maka sistem akan menyimpulkan tingkat kecanduan pengguna. Setiap aturan menghubungkan satu hipotesis (tingkat kecanduan) dengan empat gejala yang spesifik dan relevan. Dalam metode *Backward Chaining*, sistem akan memulai dari hipotesis dan menelusuri ke belakang untuk memverifikasi apakah semua gejala yang menjadi syaratnya terpenuhi. Berikut adalah Tabel 3 aturan produksi yang menggambarkan hubungan antara gejala-gejala dengan masing-masing kategori tingkat kecanduan.

Tabel 3. Tabel Aturan Gejala

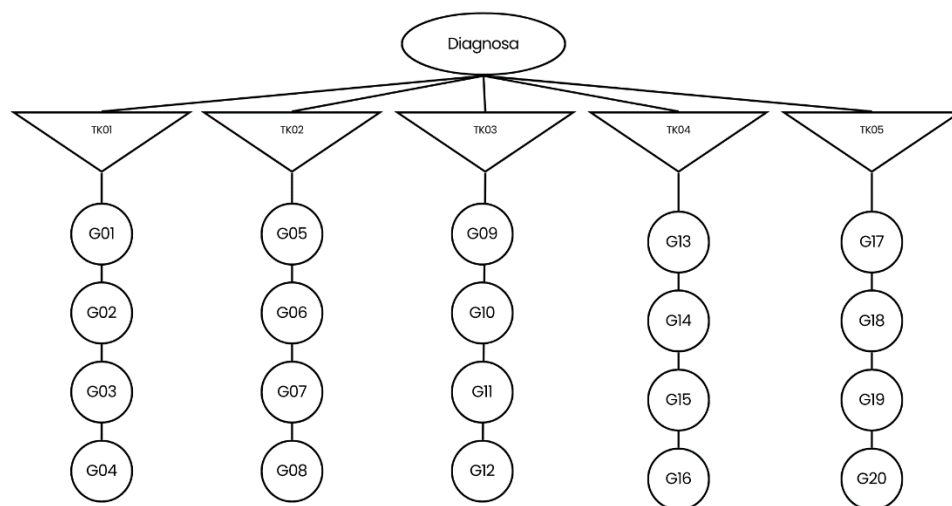
No.	Aturan Gejala
1.	IF Tidak Kecanduan (TK01) THEN Menggunakan media sosial hanya saat senggang (G01) AND Tidak merasa gelisah saat tidak membuka sosial media (G02) AND Tidak merasa harus <i>update</i> tentang aktivitas orang lain (G03) AND Bisa berhenti menggunakan media sosial kapan saja (G04)
2.	IF Mulai Berisiko (TK02) THEN Bisa berhenti menggunakan media sosial kapan saja (G05) AND Merasa perlu mengecek media sosial saat bangun tidur (G06) AND Sering mengecek notifikasi meski tidak penting (G07) AND Merasa kurang <i>update</i> jika tidak membuka media sosial (G08)
3.	IF Kecanduan Ringan (TK03) THEN Menggunakan media sosial untuk menghindari masalah pribadi (G09) AND Sering membuka media sosial saat sedang bersama keluarga/teman (G10) AND Merasa senang jika mendapat banyak <i>likes</i> atau komentar (G11) AND Gagal mengurangi waktu online meski sudah mencoba (G12)
4.	IF Kecanduan Sedang (TK04) THEN Mengabaikan pekerjaan atau tugas karena media sosial (G13) AND Sering merasa kesal jika dilarang membuka media sosial (G14) AND Sulit fokus belajar atau bekerja karena keinginan membuka media sosial (G15) AND Merasa lebih nyaman di media sosial dibanding dunia nyata (G16)

5.	IF Kecanduan Berat (TK05) THEN Menggunakan media sosial hingga larut malam hampir setiap hari (G17) AND Merasa cemas berlebihan jika tidak bisa mengakses media sosial (G18) AND Mengalami konflik serius dengan orang terdekat karena media sosial (G19) AND Lebih banyak waktu di dunia maya daripada interaksi langsung (G20)
----	---

Dengan pendekatan ini, sistem dapat melakukan diagnosis secara logis dan efisien, serta menghasilkan keputusan yang dapat ditelusuri berdasarkan data gejala yang dimasukkan oleh pengguna.

2.4 Pohon Keputusan

Pohon keputusan pada gambar di bawah merupakan representasi logika dalam proses diagnosa tingkat kecanduan media sosial berdasarkan gejala-gejala tertentu. Pohon ini dimulai dari simpul utama yang dinamakan "Diagnosa", yang kemudian bercabang menjadi lima kategori tingkat kecanduan, yaitu Tidak Kecanduan, Mulai Berisiko, Kecanduan Ringan, Kecanduan Sedang, dan Kecanduan Berat. Masing-masing kategori tersebut diidentifikasi melalui empat gejala spesifik yang tertera pada Gambar 1.



Gambar 1. Pohon Keputusan Diagnosa Kecanduan Media Sosial

2.5 Tabel Keputusan

Tabel keputusan merupakan representasi visual dari hubungan antara gejala-gejala yang dialami oleh pengguna dengan tingkat kecanduan yang mungkin terjadi.

Dalam tabel ini, setiap baris mewakili satu gejala, sedangkan setiap kolom menunjukkan salah satu dari lima tingkat kecanduan (TK01–TK05). Tanda centang dalam tabel menunjukkan bahwa gejala tersebut merupakan bagian dari aturan yang mengarah pada tingkat kecanduan tertentu. Hubungan antara masing-masing gejala dengan tingkat kecanduan yang sesuai dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Tabel Keputusan

Gejala	TK01 (Tidak Kecanduan)	TK02 (Mulai Berisiko)	TK03 (Kecanduan Ringan)	TK04 (Kecanduan Sedang)	TK05 (Kecanduan Berat)
G01	✓	-	-	-	-
G02	✓	-	-	-	-
G03	✓	-	-	-	-
G04	✓	-	-	-	-
G05	-	✓	-	-	-
G06	-	✓	-	-	-
G07	-	✓	-	-	-
G08	-	✓	-	-	-
G09	-	-	✓	-	-
G10	-	-	✓	-	-
G11	-	-	✓	-	-
G12	-	-	✓	-	-
G13	-	-	-	✓	-
G14	-	-	-	✓	-

G15	-	-	-	✓	-
G16	-	-	-	✓	-
G17	-	-	-	-	✓
G18	-	-	-	-	✓
G19	-	-	-	-	✓
G20	-	-	-	-	✓

Tabel ini berfungsi sebagai peta referensi cepat untuk melihat pola keterkaitan antara gejala dan diagnosa akhir. Dengan kata lain, tabel keputusan membantu dalam merancang dan memverifikasi basis pengetahuan dari sistem pakar, serta memperjelas logika inferensi yang digunakan oleh metode backward chaining. Penggunaan tabel ini juga memudahkan proses validasi oleh pakar dan pengembang, karena semua aturan dapat dilihat dalam satu matriks yang sistematis dan terstruktur.

2.6 Solusi dan Rekomendasi

Setelah sistem menentukan tingkat kecanduan pengguna, informasi tersebut dilengkapi dengan solusi dan rekomendasi yang disesuaikan dengan tingkat keparahan kecanduan. Solusi ini bertujuan memberikan arahan yang praktis dan mudah dipahami agar pengguna dapat segera mengambil langkah preventif atau kuratif. Rekomendasi disusun mulai dari tindakan ringan seperti mengatur waktu layar dan mengganti kebiasaan, hingga saran untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental pada tingkat kecanduan yang berat. Solusi tiap tingkat kecanduan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Tabel Solusi

Tingkat Kecanduan	Kondisi	Solusi
Tidak Kecanduan	Penggunaan sehat dan seimbang.	● Pertahankan pola penggunaan saat ini.

		• Tetap sadari waktu online agar tidak bergeser ke penggunaan berlebihan. • Gunakan media sosial untuk hal produktif atau edukatif.
Mulai Berisiko	Tanda awal kebiasaan buruk muncul.	• Tentukan waktu khusus untuk membuka media sosial (misal hanya 30 menit pagi/sore). • Matikan notifikasi yang tidak penting. • Ganti kebiasaan mengecek media sosial dengan aktivitas lain (baca buku, olahraga ringan). • Gunakan fitur “Screen Time” atau “Digital Wellbeing” di ponsel.
Kecanduan Tingkat Ringan	Media sosial digunakan sebagai pelarian dan mulai mempengaruhi emosi.	• Buat jurnal harian untuk menyadari kapan dan mengapa kamu membuka media sosial. • Latih teknik manajemen stres (seperti pernapasan atau meditasi ringan). • Terapkan social media detox ringan (1 hari tanpa medsos per minggu). • Gunakan aplikasi pembatas waktu (seperti Forest, Focus, atau AppBlock).
Kecanduan Tingkat Sedang	Aktivitas harian terganggu dan gejala kecanduan makin jelas.	• Konsultasi dengan konselor atau psikolog untuk membahas perilaku digital.

		• Batasi akses dengan menghapus aplikasi dari layar utama atau logout setelah penggunaan. • Tetapkan “zona bebas media sosial” seperti kamar tidur, ruang makan, atau waktu keluarga. • Minta dukungan teman/keluarga untuk ikut mengingatkan dan mendampingi proses pengurangan.
Kecanduan Tingkat Tinggi	Gangguan nyata terhadap kehidupan sosial, mental, dan fisik.	• Lakukan terapi perilaku kognitif (CBT) dengan profesional kesehatan mental. • Pertimbangkan program rehabilitasi digital atau digital detox camp. • Libatkan lingkungan sekitar secara aktif (keluarga, guru, teman dekat). • Buat rencana penggunaan teknologi jangka panjang dengan target dan evaluasi rutin.

Pemberian solusi ini tidak hanya menjadikan sistem pakar sebagai alat diagnosis, tetapi juga sebagai media edukasi dan pendamping awal dalam pengendalian perilaku digital yang sehat.

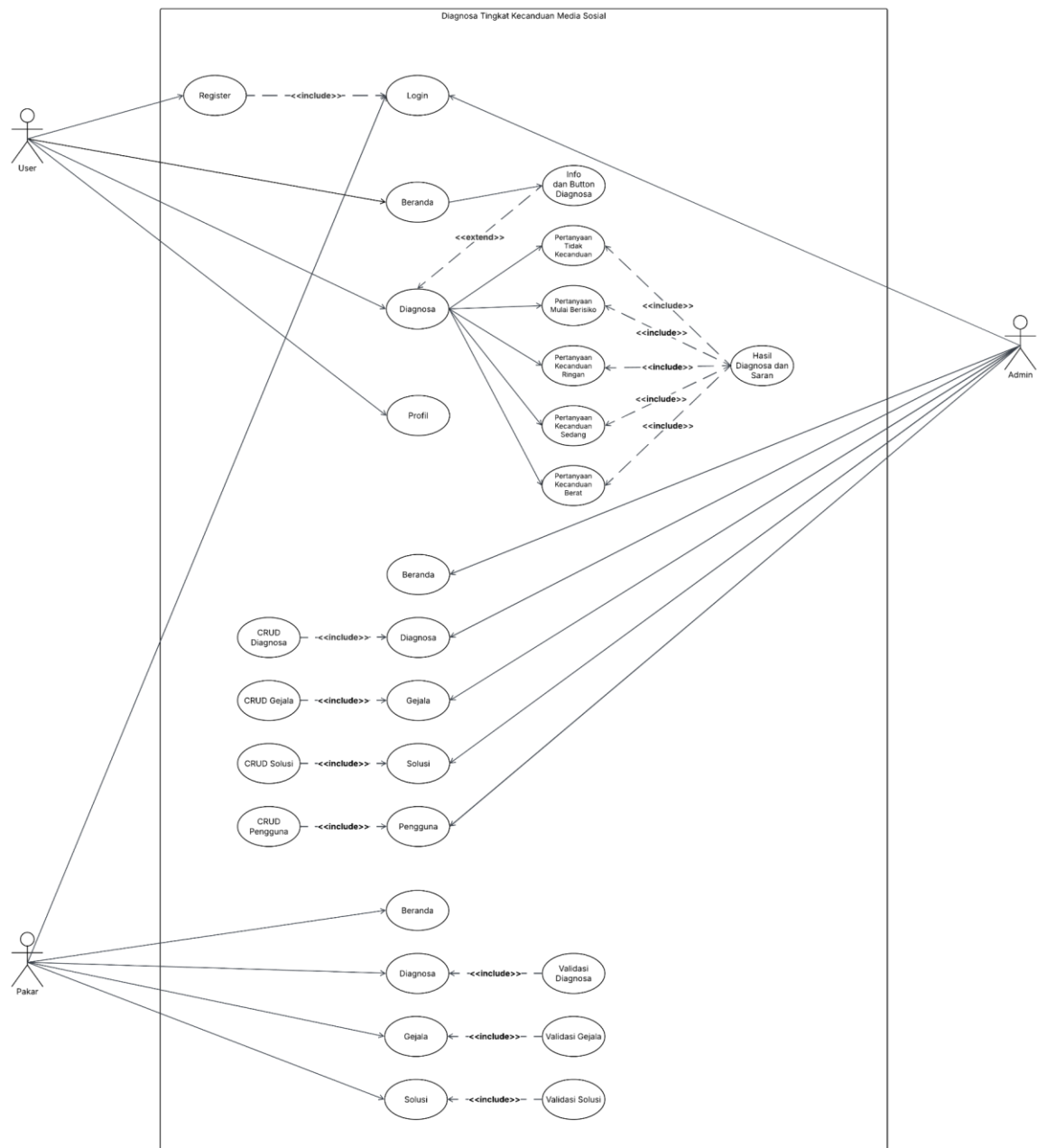
BAB III

PERANCANGAN SISTEM

Perancangan sistem bertujuan untuk menjelaskan cara pembuatan sistem pakar dan cara setiap bagian berinteraksi selama proses konsultasi. Proses perancangan menggunakan metode UML (*Unified Modeling Language*) dan model basis data relasional untuk mendukung penyimpanan serta pengelolaan informasi.

3.1 Use Case Diagram

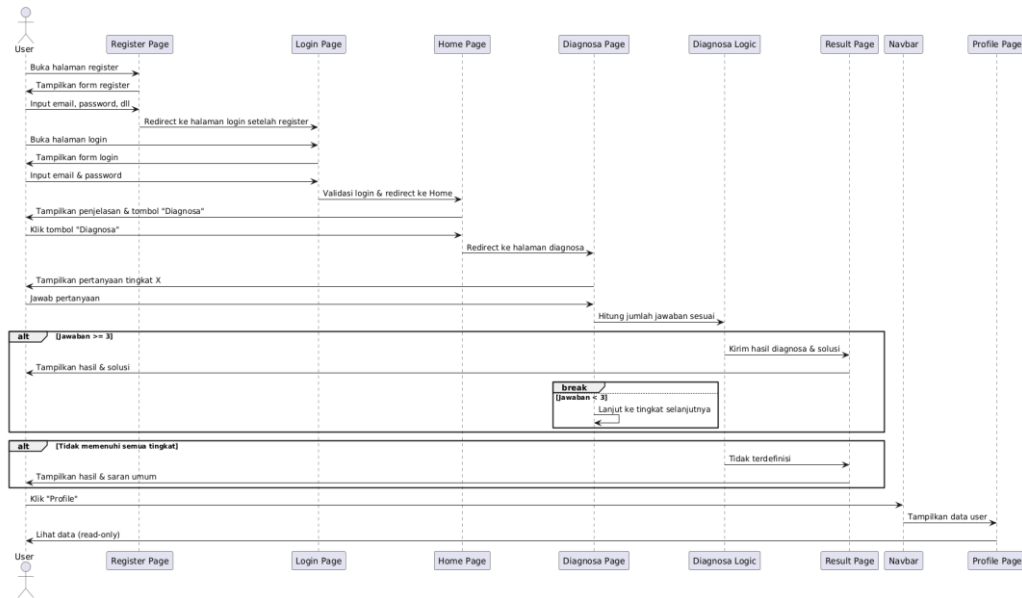
Use Case Diagram menunjukkan fungsi-fungsi dari sistem dari sudut pandang pengguna. Dalam sistem ini terdapat tiga peran utama, yaitu Admin, *User*, dan Pakar. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data gejala, penyakit (diagnosa), dan data user. Admin bertanggung jawab memastikan seluruh data yang ada di dalam sistem terstruktur dengan baik dan siap digunakan dalam proses diagnosis. *User* adalah pengguna umum yang dapat melakukan konsultasi dengan memilih gejala-gejala yang dirasakan. Berdasarkan gejala yang dipilih, sistem akan memberikan hasil diagnosis serta saran atau solusi yang sebaiknya dilakukan oleh user. Sementara itu, Pakar berperan dalam memverifikasi data gejala, diagnosa, dan solusi yang ada di sistem. Verifikasi dari Pakar diperlukan untuk menjamin bahwa informasi yang tersedia dalam sistem akurat dan sesuai dengan keilmuan di bidangnya. Dengan demikian, diagram ini berfungsi untuk mengenali kebutuhan sistem secara fungsional dan memastikan bahwa setiap kebutuhan dari masing-masing pengguna dapat terpenuhi dengan baik. Hubungan antar pengguna dan sistem divisualisasikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Use Case Diagram

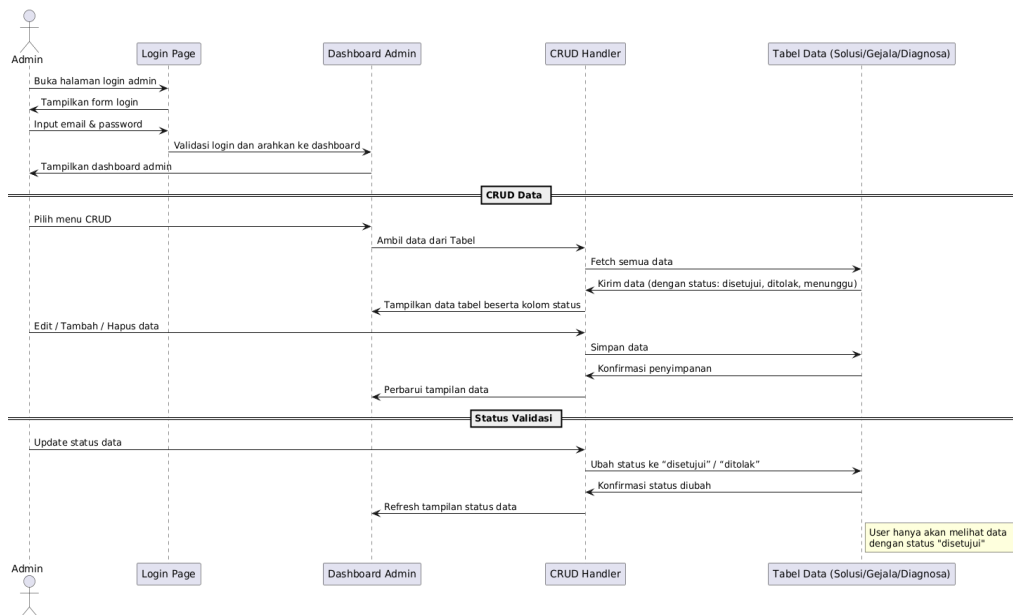
3.2 Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan alur interaksi antar objek dalam sistem secara berurutan. Diagram ini digunakan untuk memperjelas proses dari pengguna memilih gejala sampai sistem memberikan hasil diagnosis. Dengan *sequence* diagram, alur sistem bisa dipahami lebih mudah dan membantu dalam implementasi nantinya. Gambar 3 berikut merupakan *Sequence Diagram* untuk *User*.



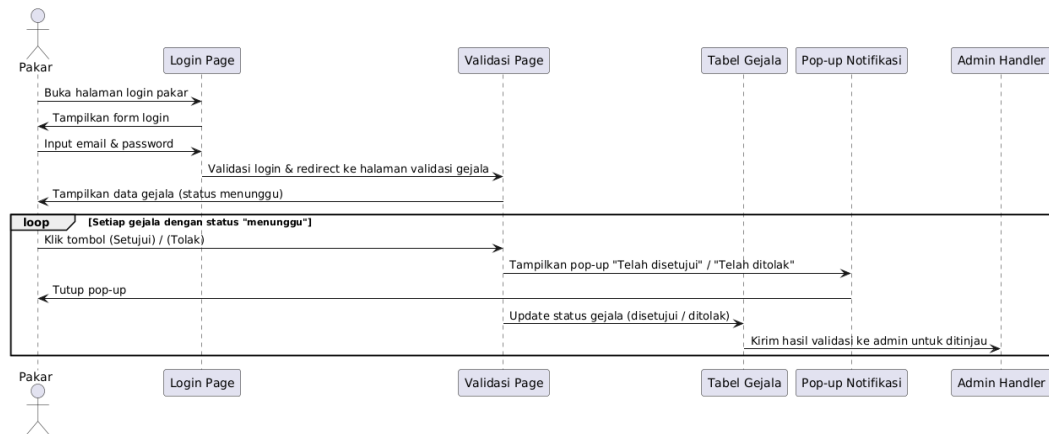
Gambar 3. *Sequence Diagram* untuk User

Kemudian berikut *Sequence Diagram* untuk Admin yang terdapat pada Gambar 4.



Gambar 4. *Sequence Diagram* untuk Admin

Kemudian juga terdapat *Sequence Diagram* untuk Pakar yang bisa dilihat pada Gambar 5.

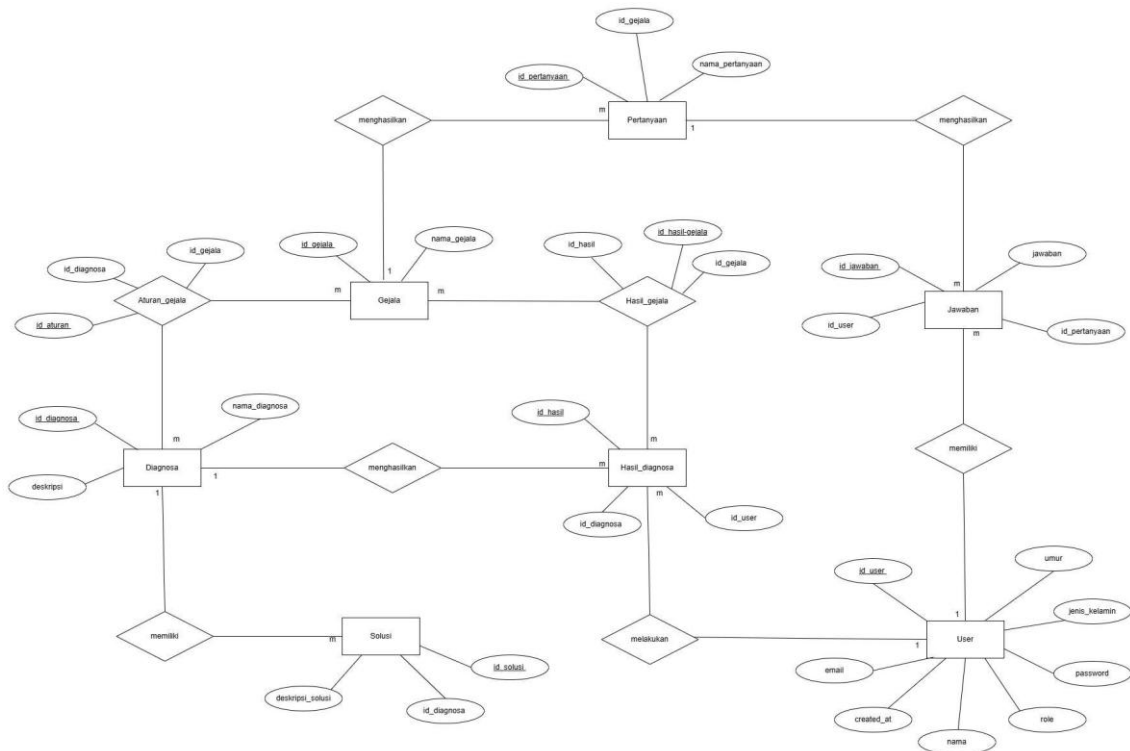


Gambar 5. *Sequence Diagram* untuk Pakar

3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan representasi visual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem. ERD membantu dalam merancang *database* dengan memetakan tabel-tabel yang dibutuhkan serta bagaimana data tersebut saling terhubung. Dengan ERD, pengembang bisa memahami secara jelas hubungan antar data sehingga memudahkan proses penyimpanan, pengambilan, dan pengelolaan informasi dalam aplikasi.

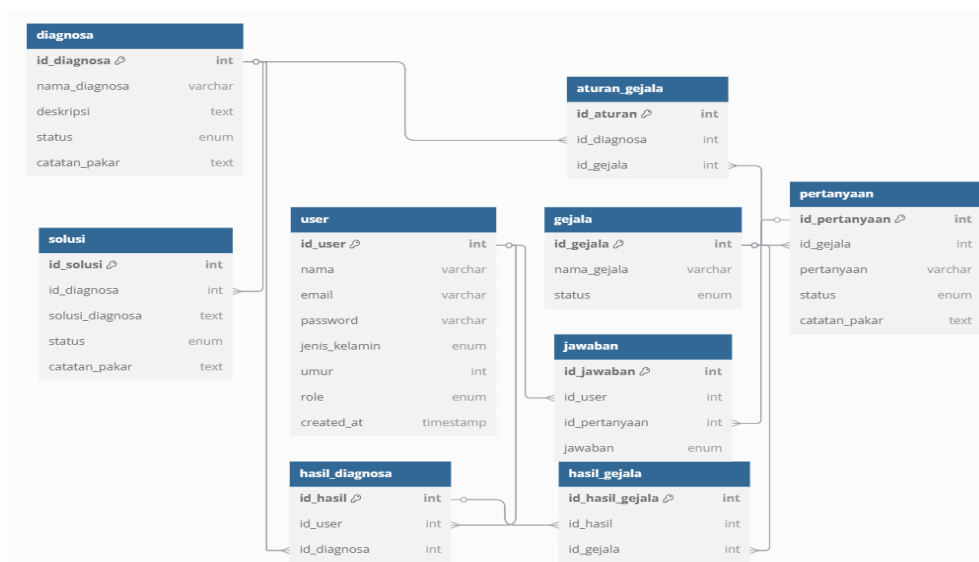
Dalam sistem pakar diagnosis kecanduan media sosial ini, ERD menggambarkan entitas utama seperti pengguna (*user*), gejala, diagnosa, hasil diagnosa, solusi, dan lainnya. Misalnya, satu pengguna bisa memiliki banyak hasil diagnosa, sebuah diagnosa bisa memiliki banyak gejala melalui aturan tertentu, dan setiap diagnosa juga memiliki solusi yang sesuai. Dengan struktur yang jelas ini, sistem dapat mengelola data dengan efisien dan menyediakan hasil diagnosis lengkap beserta solusi yang tepat untuk pengguna. Pada Gambar 6 ditunjukkan diagram ERD yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem pakar diagnosis tingkat kecanduan media sosial.



Gambar 6. Entity Relationship Diagram

3.4 Struktur Tabel Database

Tabel *database* disusun berdasarkan ERD yang sudah dibuat. Setiap entitas dijadikan satu tabel, lengkap dengan atributnya. Tujuannya supaya data bisa disimpan dengan efisien dan mudah dikelola, mulai dari input gejala sampai hasil diagnosis pengguna., yang dapat dilihat pada Gambar 7.



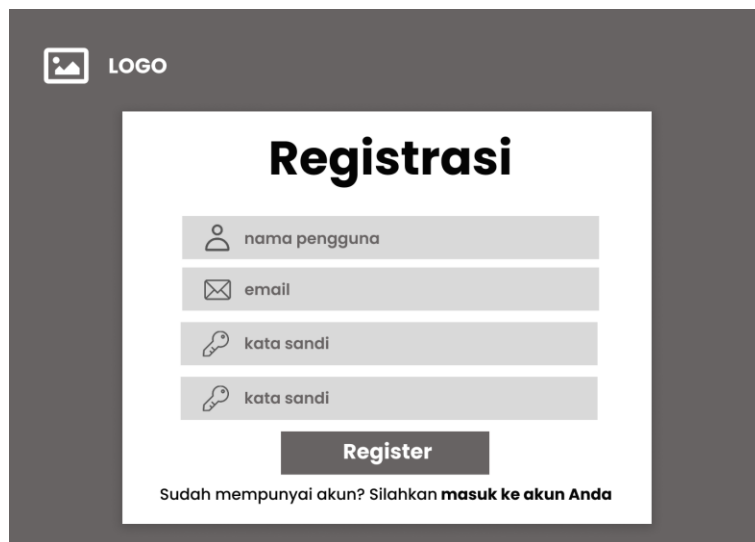
Gambar 7. Tabel Database Sistem Pakar Kecanduan Media Sosial

IV

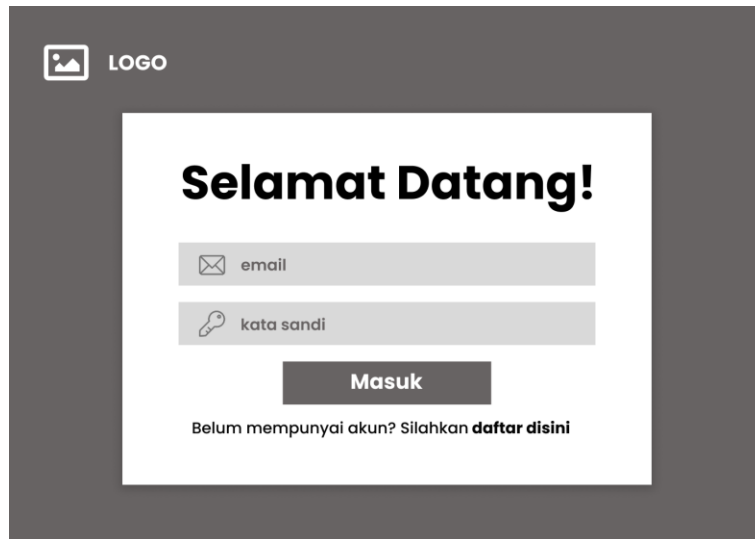
IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Rancangan *Wireframe* Antarmuka

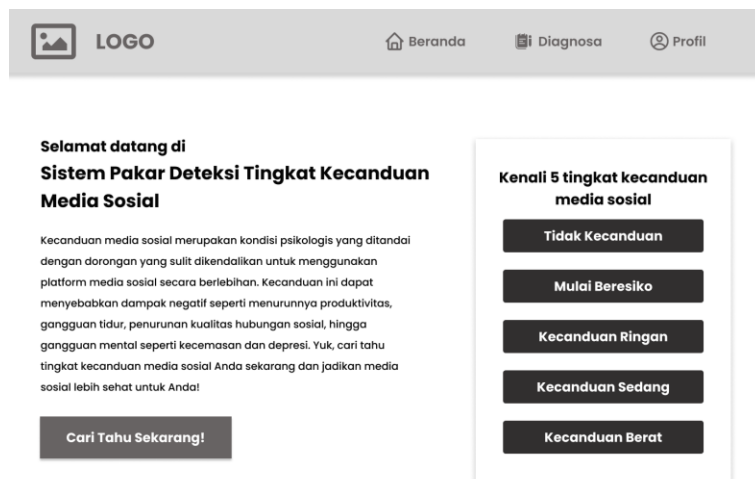
Wireframe merupakan rancangan awal dari antarmuka pengguna yang dibuat untuk memvisualisasikan struktur halaman sebelum diimplementasikan ke dalam bentuk sistem yang sebenarnya. Tujuan dari pembuatan *wireframe* adalah untuk memberikan gambaran kasar mengenai letak elemen-elemen penting dalam antarmuka, seperti tombol, form input, teks, dan navigasi. Rancangan ini membantu pengembang dan desainer untuk menyusun tata letak yang logis, fungsional, dan mudah digunakan, serta memungkinkan terjadinya revisi lebih awal sebelum tahap pengkodean dimulai. Rancangan *wireframe* SOSMEDCARE disajikan pada Gambar 8 sampai Gambar 42.



Gambar 8. Perancangan Halaman Registrasi



Gambar 9. Perancangan Halaman Login



Gambar 10. Perancangan Halaman Beranda User

Tes Tingkat Kecanduan Media Sosial

Seberapa terikat Anda pada media sosial? Yuk, ikuti tes ini untuk mengetahui tingkat kecanduan Anda dan ambil langkah pertama untuk mengendalikannya!

Mulai Tes

Gambar 11. Perancangan Halaman Diagnosa User

 LOGO

[Beranda](#) [Diagnosa](#) [Profil](#)

Tingkat Tidak Kecanduan

Menggunakan media sosial hanya saat waktu senggang?
☐ Ya ☐ Tidak

Tidak merasa gelisah saat tidak membuka media sosial?
☐ Ya ☐ Tidak

Tidak merasa harus tahu semua aktivitas orang lain di media sosial?
☐ Ya ☐ Tidak

Bisa berhenti menggunakan media sosial kapan pun?
☐ Ya ☐ Tidak

Cek Hasil

© 2025, SOSMEDCARE

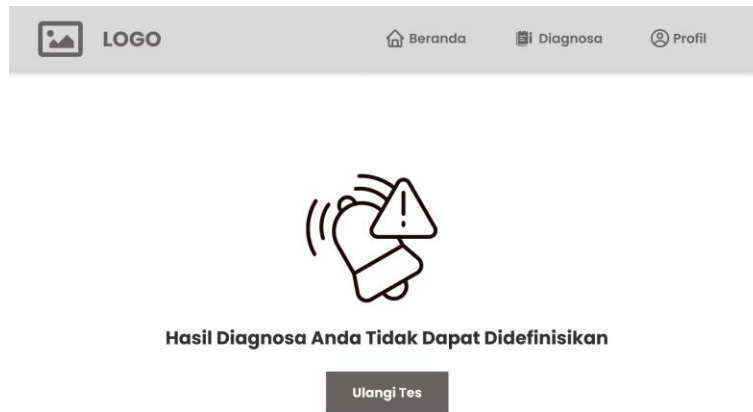
Gambar 12. Perancangan Halaman Pertanyaan



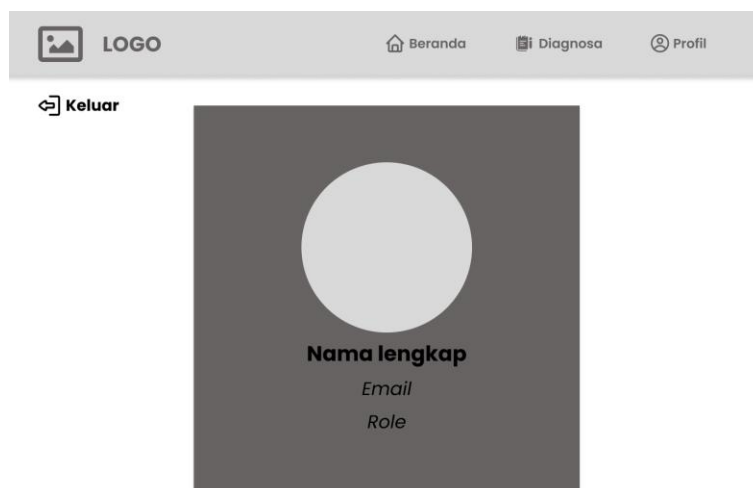
Gambar 13. Perancangan Halaman Hasil Diagnosa



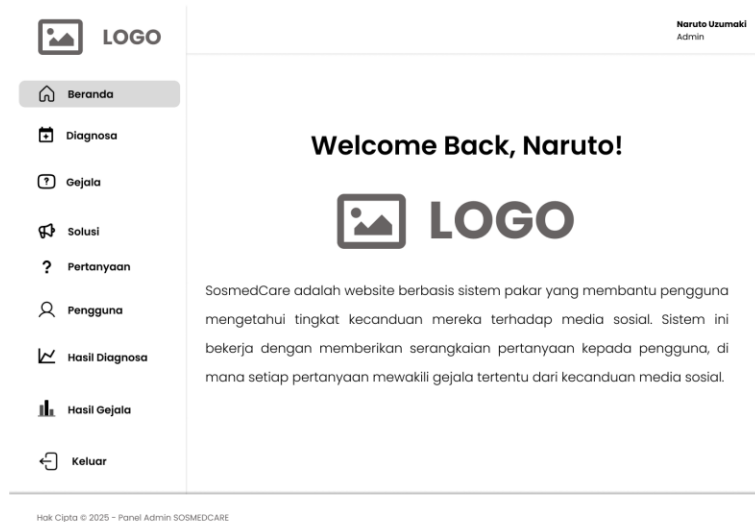
Gambar 14. Perancangan Halaman Lanjutkan Tes



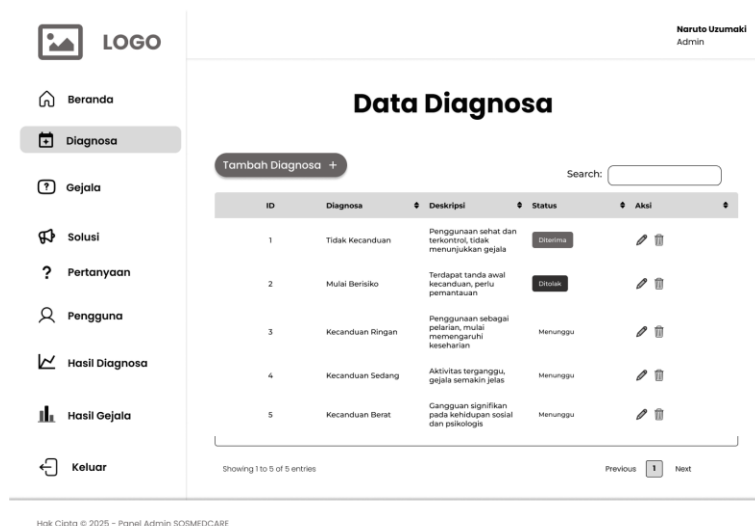
Gambar 15. Perancangan Halaman Identifikasi Gagal



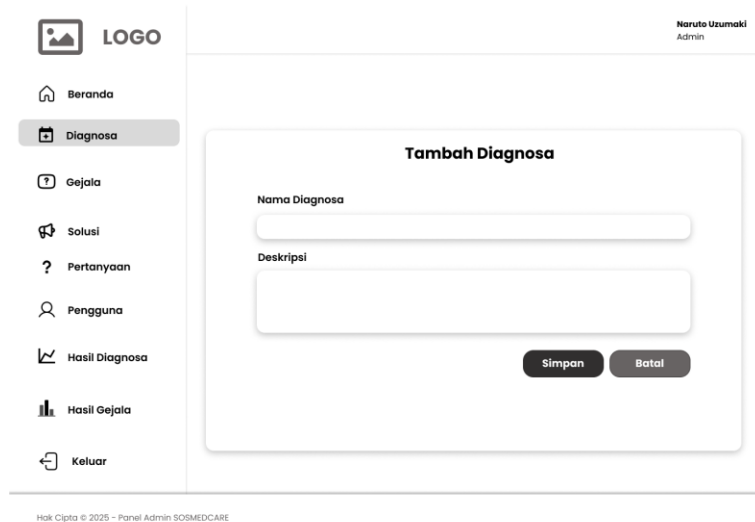
Gambar 16. Perancangan Halaman Profil User



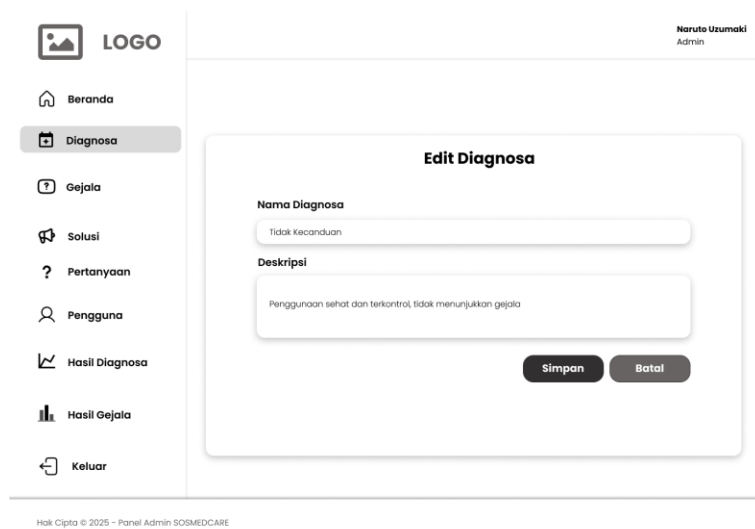
Gambar 17. Perancangan Halaman Beranda Admin



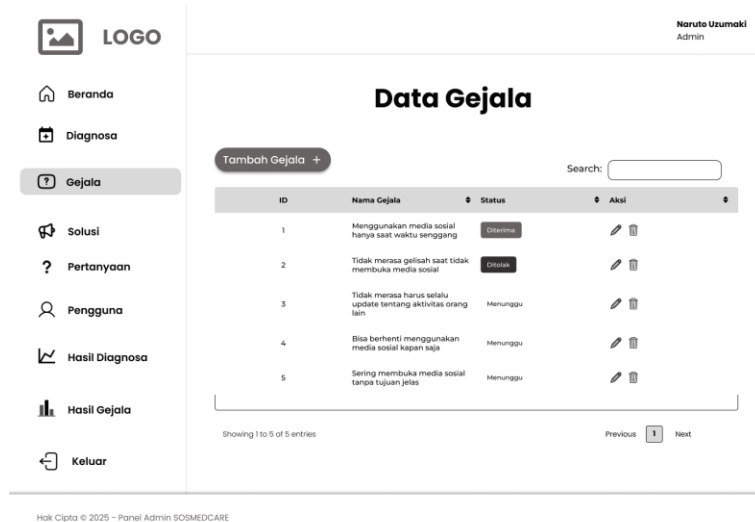
Gambar 18. Perancangan Halaman Data Diagnosa



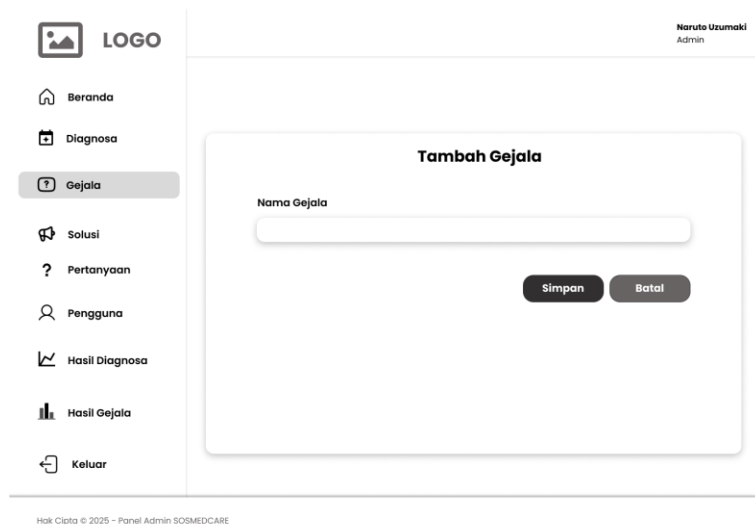
Gambar 19. Perancangan Halaman Tambah Diagnosa



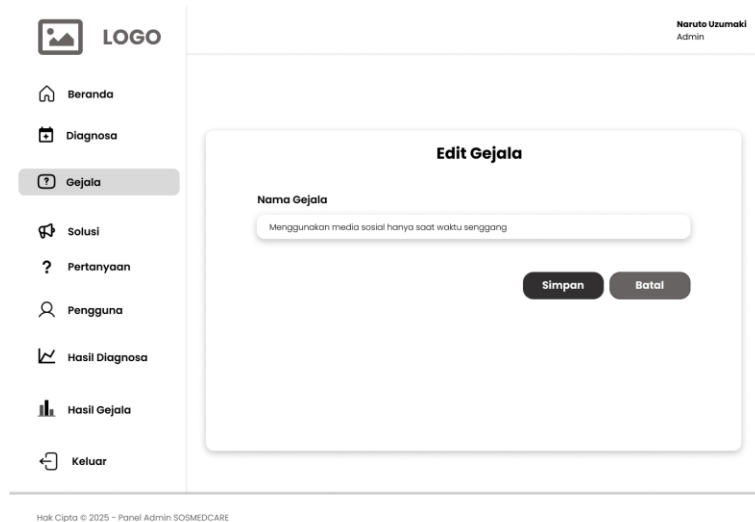
Gambar 20. Perancangan Halaman Edit Diagnosa



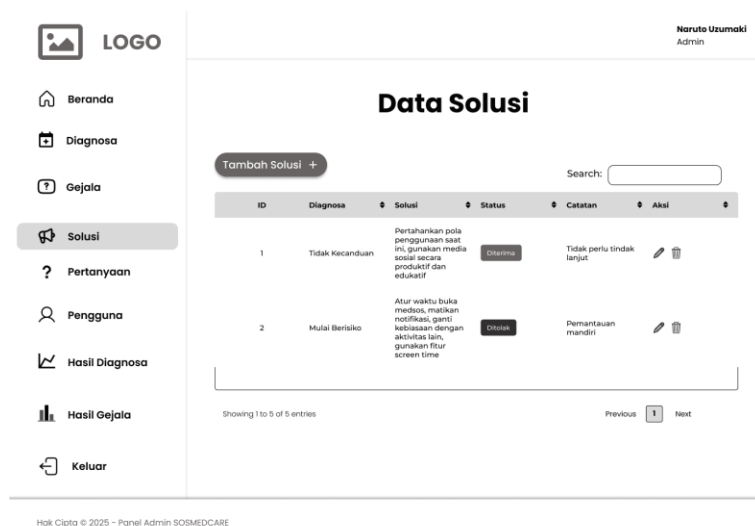
Gambar 21. Perancangan Halaman Data Gejala



Gambar 22. Perancangan Halaman Tambah Gejala



Gambar 23. Perancangan Halaman Edit Gejala



Gambar 24. Perancangan Halaman Data Solusi

LOGO

Naruto Uzumaki
Admin

Beranda

Diagnosa

Gejala

Solusi

Pertanyaan

Pengguna

Hasil Diagnosa

Hasil Gejala

Keluar

Tambah Solusi

Diagnosa

-- Pilih Diagnosa --

Solusi

Simpan Batal

Hak Cipta © 2025 - Panel Admin SOSMEDCARE

Gambar 25. Perancangan Halaman Tambah Solusi

LOGO

Naruto Uzumaki
Admin

Beranda

Diagnosa

Gejala

Solusi

Pertanyaan

Pengguna

Hasil Diagnosa

Hasil Gejala

Keluar

Edit Solusi

Diagnosa

Tidak Kecanduan

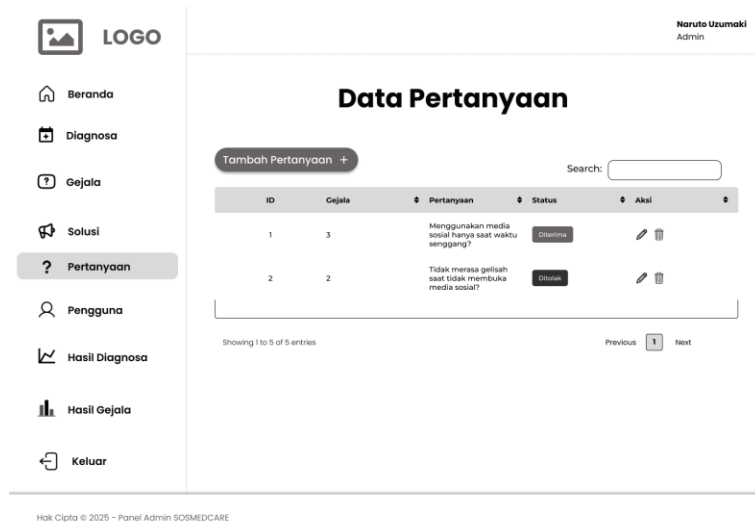
Solusi

Pertahankan pola penggunaan saat ini, gunakan media sosial secara produktif dan edukatif

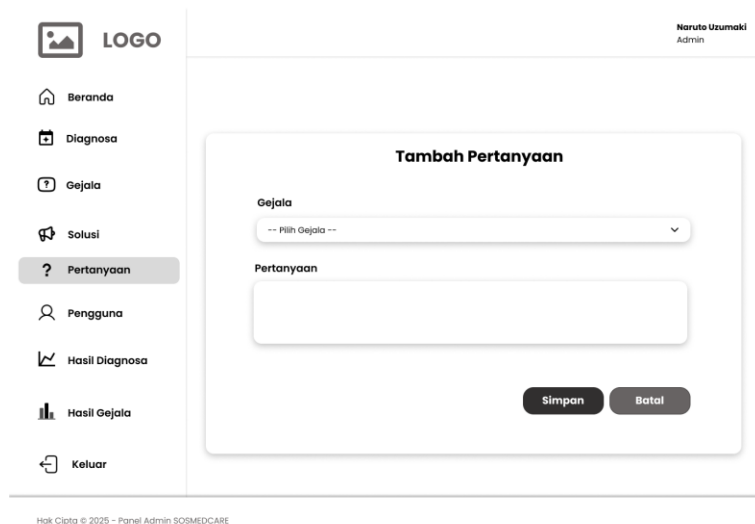
Simpan Batal

Hak Cipta © 2025 - Panel Admin SOSMEDCARE

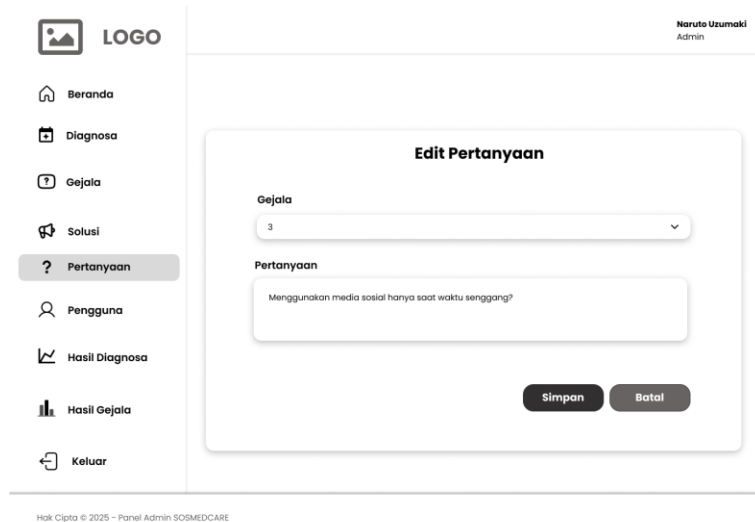
Gambar 26. Perancangan Halaman Edit Solusi



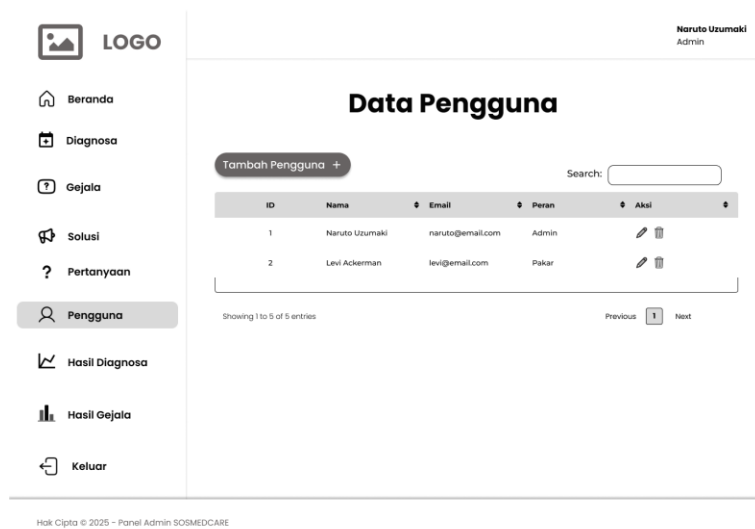
Gambar 27. Perancangan Halaman Data Pertanyaan



Gambar 28. Perancangan Halaman Tambah Pertanyaan



Gambar 29. Perancangan Halaman Edit Pertanyaan



Gambar 30. Perancangan Halaman Data Pengguna

LOGO

Beranda

Diagnosa

Gejala

Solusi

Pertanyaan

Pengguna

Hasil Diagnosa

Hasil Gejala

Keluar

Naruto Uzumaki
Admin

Tambah Pengguna

Nama

Email

Password

Role

-- Pilih Role --

Simpan

Batal

Hak Cipta © 2025 - Panel Admin SOMEDCARE

Gambar 31. Perancangan Halaman Tambah Pengguna

LOGO

Beranda

Diagnosa

Gejala

Solusi

Pertanyaan

Pengguna

Hasil Diagnosa

Hasil Gejala

Keluar

Naruto Uzumaki
Admin

Edit Pengguna

Nama

Uzumaki Naruto

Email

naruto@email.com

Password

naruto123

Role

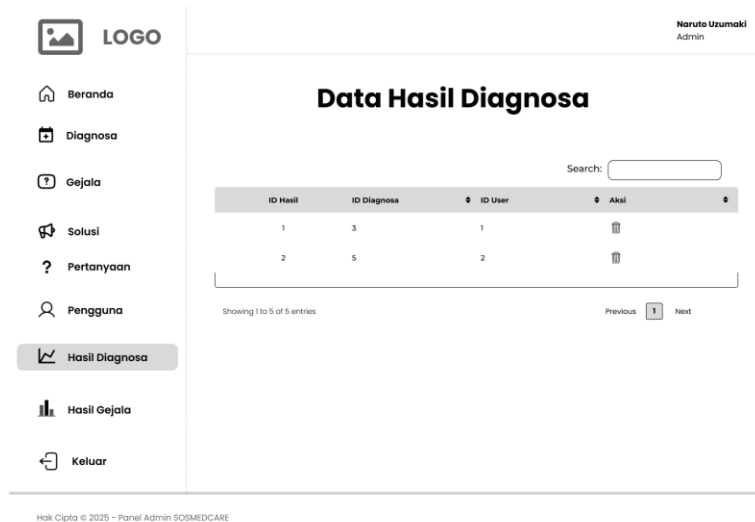
Admin

Simpan

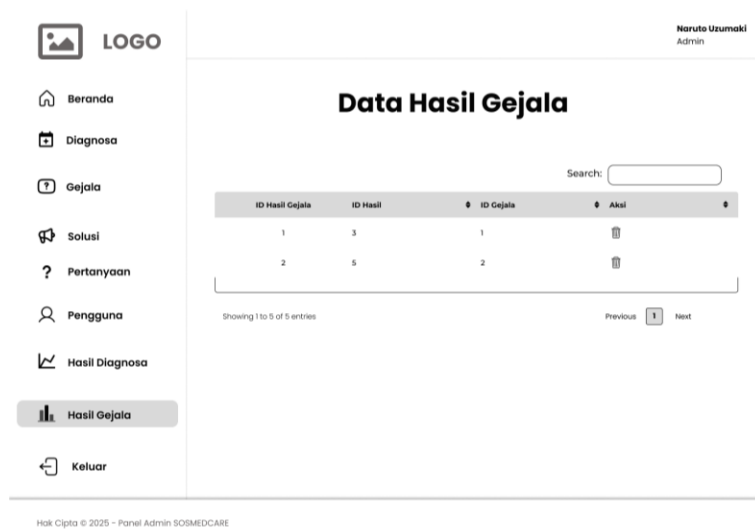
Batal

Hak Cipta © 2025 - Panel Admin SOMEDCARE

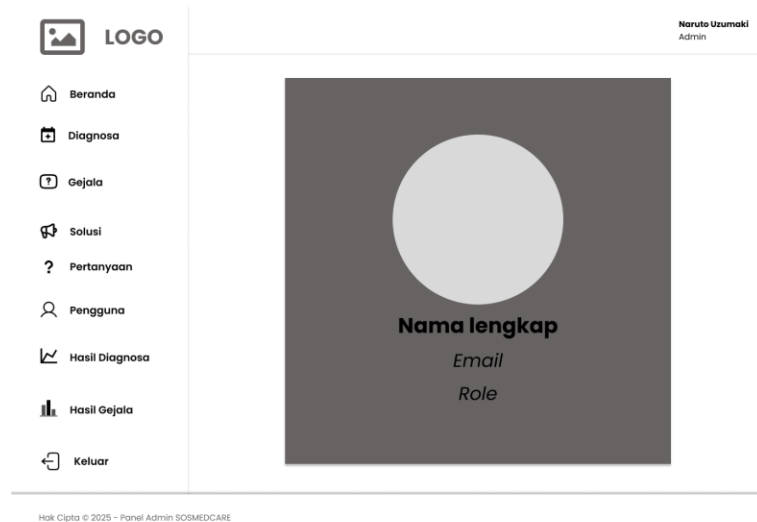
Gambar 32. Perancangan Halaman Edit Pengguna



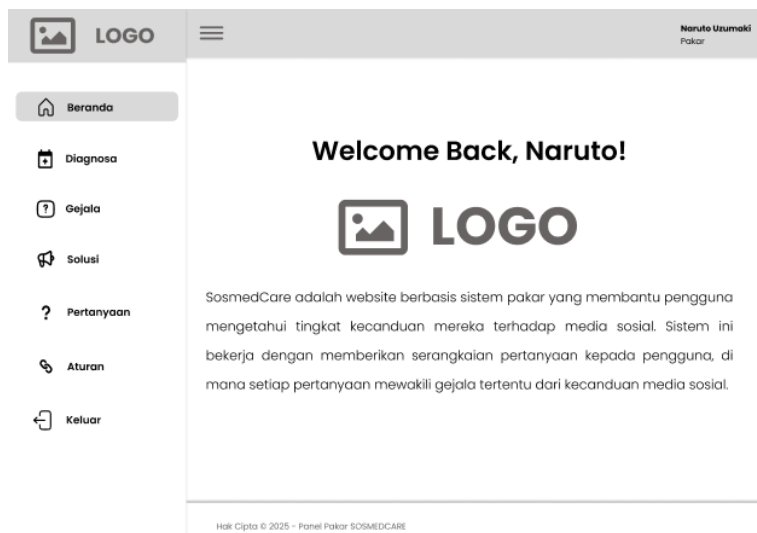
Gambar 33. Perancangan Halaman Data Hasil Diagnosa



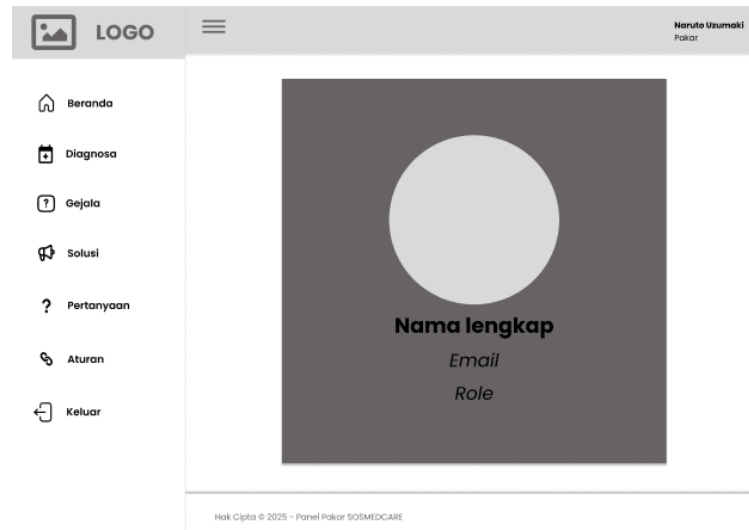
Gambar 34. Perancangan Halaman Data Hasil Gejala



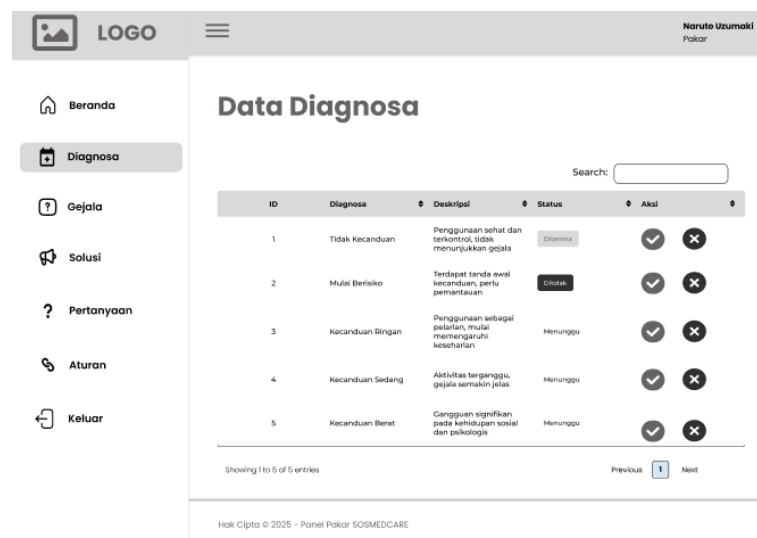
Gambar 35. Perancangan Halaman Profil Admin



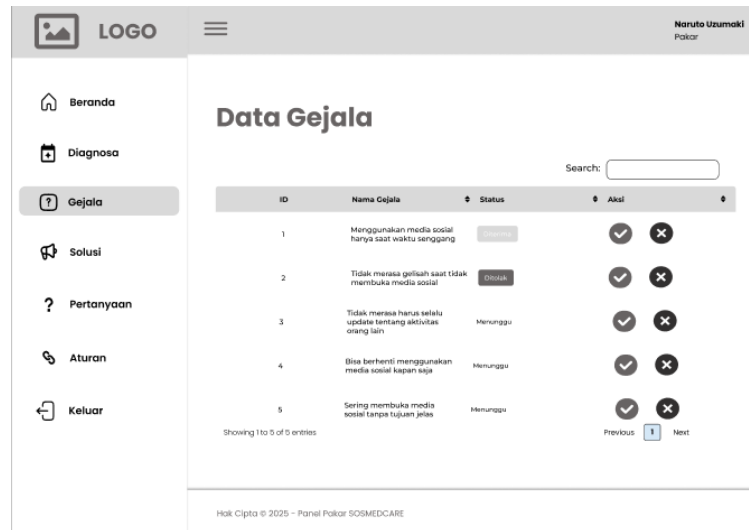
Gambar 36. Perancangan Halaman Beranda Pakar



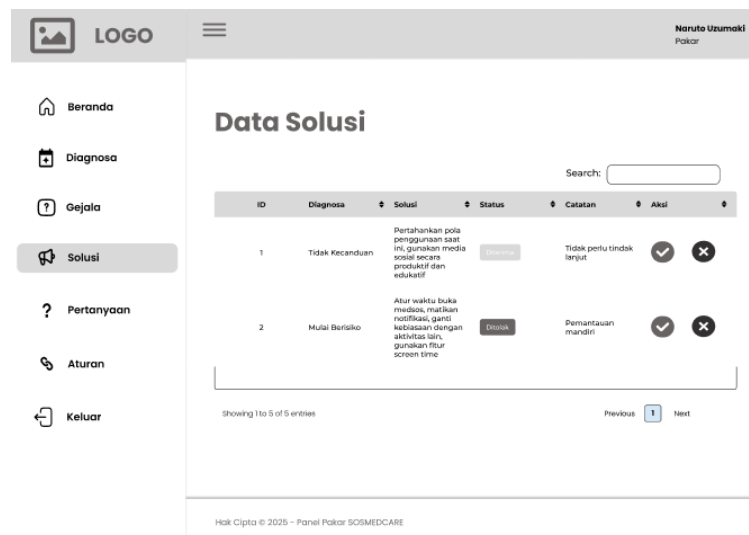
Gambar 37. Perancangan Halaman Profil Pakar



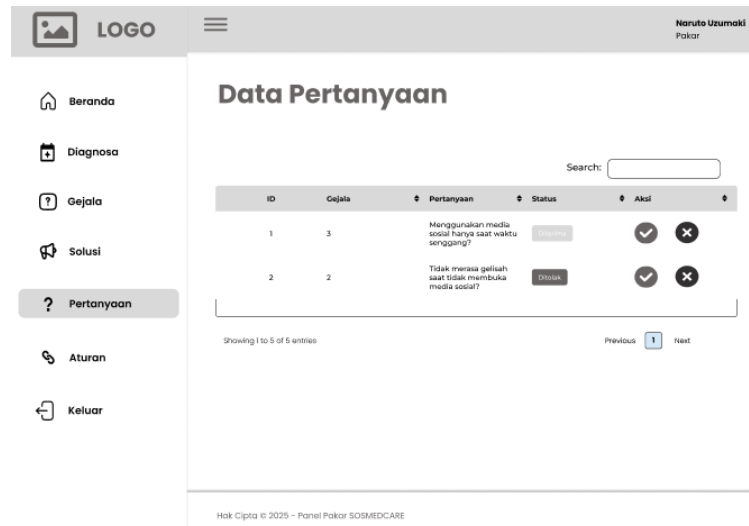
Gambar 38. Perancangan Halaman Verifikasi Diagnosa



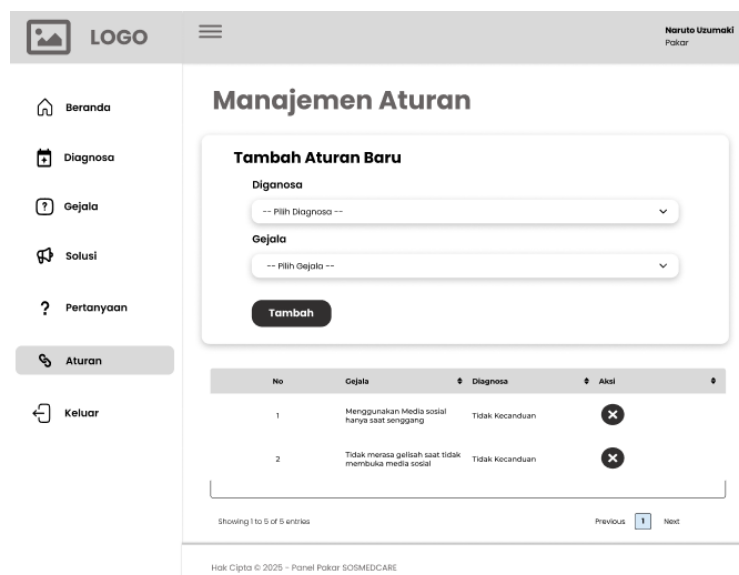
Gambar 39. Perancangan Halaman Verifikasi Gejala



Gambar 40. Perancangan Halaman Verifikasi Solusi



Gambar 41. Perancangan Halaman Verifikasi Pertanyaan



Gambar 42. Perancangan Halaman Verifikasi Aturan

4.2 Implementasi Website Sistem Pakar

Sistem pakar untuk mendiagnosis tingkat kecanduan media sosial ini diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis *website* agar dapat diakses secara luas dan fleksibel oleh pengguna dari berbagai perangkat. Platform berbasis web dipilih karena keunggulannya dalam hal kemudahan akses, tidak memerlukan instalasi lokal, dan dapat dijalankan melalui *browser* secara *real-time*.

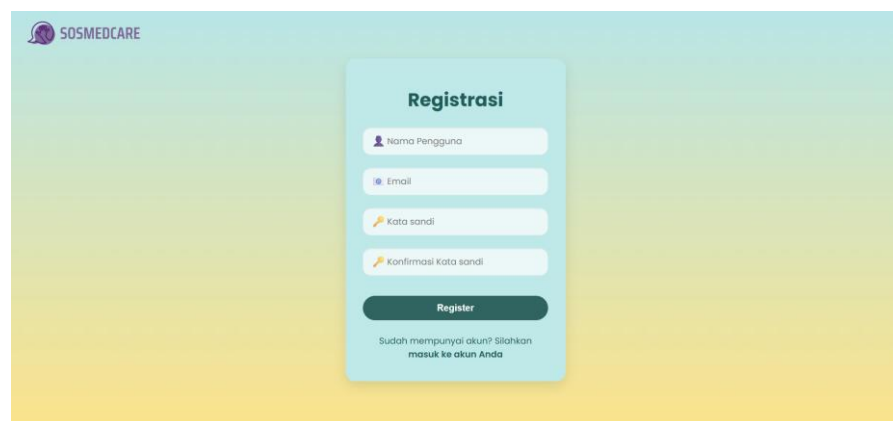
Dalam pengembangannya, sistem ini dibangun menggunakan:

- Bahasa pemrograman: PHP
- Framework: Laravel
- Basis data: SQLite
- Teknologi pendukung: HTML, CSS, JavaScript (untuk antarmuka)

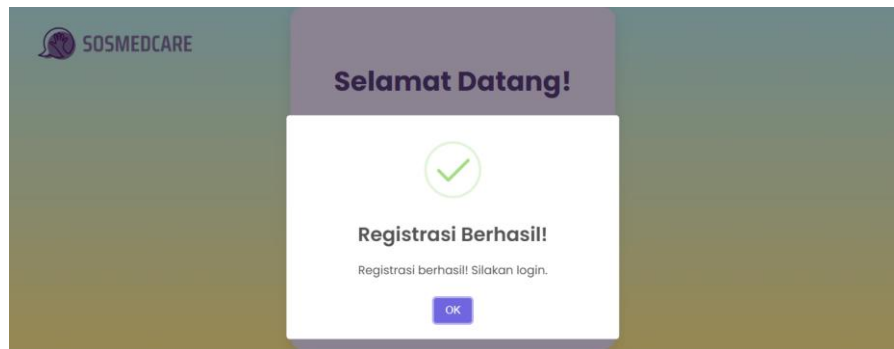
Sistem bekerja berdasarkan metode *backward chaining*, di mana inferensi dilakukan dari hipotesis (tingkat kecanduan) ke data gejala pengguna. Seluruh logika inferensi dan pemrosesan data dilakukan di sisi *server*, sementara pengguna hanya berinteraksi melalui antarmuka yang intuitif. Berikut beberapa fitur utama yang diimplementasikan dalam sistem:

4.2.1 Halaman Registrasi

Halaman ini menampilkan formulir pendaftaran yang digunakan oleh pengguna baru untuk membuat akun. Elemen-elemen yang disediakan mencakup kolom input nama pengguna, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Tersedia pula tombol “Register” untuk mengirim data, serta tautan di bagian bawah bagi pengguna yang sudah memiliki akun agar dapat langsung menuju halaman login. Halaman registrasi ini dapat dilihat pada Gambar 43 dan Gambar 44.



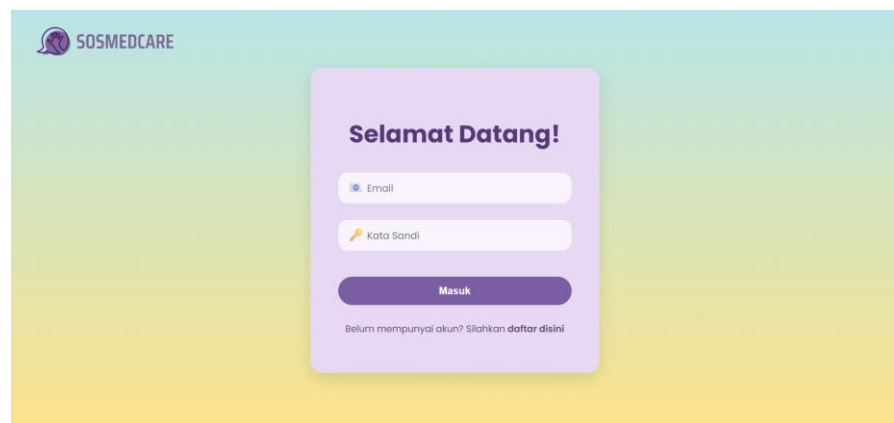
Gambar 43. Halaman Registrasi



Gambar 44. Pop Up Registrasi Berhasil

4.2.2 Halaman Login untuk Autentikasi Pengguna (Admin, User, dan Pakar)

Halaman login dirancang agar pengguna dapat melakukan autentikasi sebelum masuk ke sistem. Di dalamnya terdapat dua kolom input yaitu email dan kata sandi, serta tombol “Masuk”. Pada bagian bawah terdapat tautan bagi pengguna yang belum memiliki akun untuk menuju halaman registrasi. Halaman login ditampilkan pada Gambar 45.

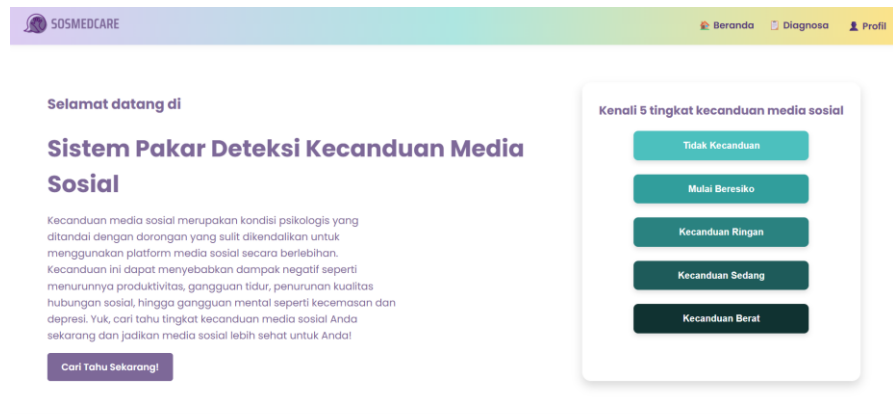


Gambar 45. Halaman Login

4.2.3 Halaman Beranda

Halaman ini menjadi tampilan utama yang pertama kali dilihat pengguna setelah login. Terdapat penjelasan singkat mengenai tujuan sistem pakar dan pentingnya deteksi dini kecanduan media sosial. Di sebelah kanan halaman ditampilkan lima kategori tingkat kecanduan, serta tombol “Cari

Tahu Sekarang!” sebagai pintu masuk menuju proses diagnosis. Halaman beranda ini dapat dilihat pada Gambar 46.



Gambar 46. Halaman Beranda User

4.2.4 Halaman Awal Diagnosa

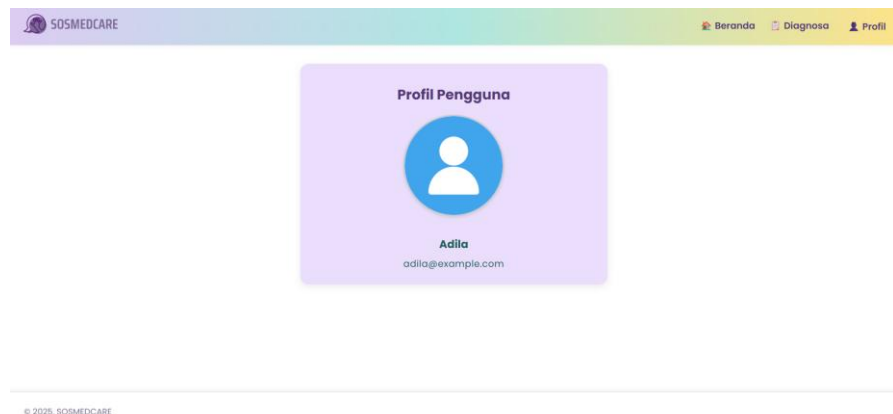
Halaman ini memperlihatkan halaman awal sebelum pengguna memasuki proses diagnosis. Halaman ini memberikan instruksi dan ajakan kepada pengguna untuk mengikuti tes deteksi tingkat kecanduan, lengkap dengan tombol “Mulai Tes” sebagai aksi utama yang ketika di klik maka user akan diarahkan ke halaman tes diagnosa yang berisi pertanyaan untuk tiap diagnosa. Halaman awal diagnosa ini ditunjukkan pada Gambar 47.



Gambar 47. Halaman Awal Diagnosa

4.2.5 Halaman Profil

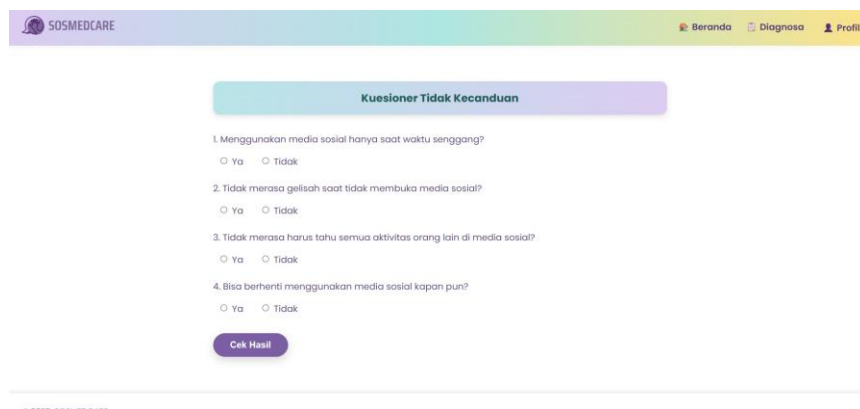
Halaman ini menyajikan informasi pribadi pengguna mencakup nama lengkap, alamat email, jenis kelamin, dan umur. Di bagian kiri atas terdapat tombol “Keluar” untuk logout dari sistem. Halaman profil ini digambarkan dalam Gambar 48.



Gambar 48. Halaman Profil User

4.2.6 Halaman Pertanyaan Tingkat Tidak Kecanduan

Pada tahap ini, sistem menampilkan serangkaian pertanyaan kepada pengguna yang berhubungan dengan kebiasaan penggunaan media sosial. Pertanyaan dirancang untuk mengidentifikasi apakah pengguna termasuk dalam kategori “Tidak Kecanduan”. Jawaban diberikan dalam bentuk pilihan Ya atau Tidak, dan diakhiri dengan tombol “Cek Hasil”. Tampilan untuk kategori ini dapat dilihat pada Gambar 49.



Gambar 49. Halaman Pertanyaan Tingkat Tidak Kecanduan

4.2.7 Halaman Pertanyaan Tingkat Mulai Berisiko

Halaman ini berisi empat pertanyaan yang ditujukan untuk mendeteksi kecenderungan awal terhadap kecanduan media sosial. Pertanyaan difokuskan pada kebiasaan pengguna yang mulai menunjukkan pola tidak sehat dalam menggunakan media sosial. Desain halaman ini dijelaskan pada Gambar 50.

SOSMEDCARE Beranda Diagnosa Profil

Kuesioner Mulai Berisiko

1. Sering membuka media sosial tanpa alasan jelas?
☐ Ya ☐ Tidak

2. Langsung mengecek media sosial begitu bangun tidur?
☐ Ya ☐ Tidak

3. Sering mengecek notifikasi meski tidak penting?
☐ Ya ☐ Tidak

4. Merasa kurang update jika tidak membuka media sosial dalam sehari?
☐ Ya ☐ Tidak

Cek Hasil

Gambar 50. Halaman Pertanyaan Tingkat Mulai Berisiko

4.2.8 Halaman Pertanyaan Tingkat Kecanduan Ringan

Halaman ini berisi pertanyaan yang mencerminkan interaksi emosional pengguna dengan media sosial, seperti keinginan untuk mendapat validasi dari like atau komentar, serta penggunaan media sosial sebagai pelarian. Halaman tingkat kecanduan ringan ini dapat dilihat pada Gambar 51.

SOSMEDCARE Beranda Diagnosa Profil

Kuesioner Kecanduan Ringan

1. Menggunakan media sosial untuk menghindari masalah pribadi?
☐ Ya ☐ Tidak

2. Membuka media sosial saat sedang berkumpul dengan keluarga/teman?
☐ Ya ☐ Tidak

3. Merasa senang jika mendapat banyak like/komentar?
☐ Ya ☐ Tidak

4. Gagal mengurangi waktu online meskipun sudah mencoba?
☐ Ya ☐ Tidak

Cek Hasil

Gambar 51. Halaman Pertanyaan Tingkat Kecanduan Ringan

4.2.9 Halaman Pertanyaan Tingkat Kecanduan Sedang

Pada kategori ini, sistem menampilkan pertanyaan yang menunjukkan bahwa media sosial mulai mengganggu produktivitas pengguna, seperti menurunnya fokus, marah ketika dilarang mengakses, dan mengabaikan tugas penting. Halaman ini ditampilkan dalam Gambar 52.

SOSMEDCARE Beranda Diagnosa Profil

Kuesioner Kecanduan Sedang

1. Mengabaikan pekerjaan atau tugas penting karena sibuk di media sosial?
☐ Ya ☐ Tidak

2. Sering marah/kesal saat dilarang membuka media sosial?
☐ Ya ☐ Tidak

3. Sulit fokus belajar/kerja karena ingin membuka media sosial?
☐ Ya ☐ Tidak

4. Merasa lebih nyaman hidup di media sosial daripada dunia nyata?
☐ Ya ☐ Tidak

Cek Hasil

© 2025, SOSMEDCARE

Gambar 52. Halaman Pertanyaan Tingkat Kecanduan Sedang

4.2.10 Halaman Pertanyaan Tingkat Kecanduan Berat

Halaman ini menunjukkan pertanyaan yang berkaitan dengan dampak serius dari kecanduan media sosial, termasuk gangguan tidur, kecemasan ekstrem, dan konflik sosial. Pertanyaan ini digunakan untuk menentukan apakah pengguna sudah berada dalam tahap kecanduan berat. Rancangan visual untuk halaman ini dapat dilihat pada Gambar 53.

Kuesioner Kecanduan Berat

1. Sering menggunakan media sosial hingga larut malam setiap hari?
☐ Ya ☐ Tidak
2. Merasa sangat cemas jika tidak bisa mengakses media sosial?
☐ Ya ☐ Tidak
3. Sering berkonflik dengan orang terdekat karena penggunaan media sosial?
☐ Ya ☐ Tidak
4. Lebih banyak waktu online daripada berinteraksi langsung di dunia nyata?
☐ Ya ☐ Tidak

Cek Hasil

Gambar 53. Halaman Pertanyaan Tingkat Kecanduan Berat

4.2.11 Halaman Hasil Diagnosa Tidak Kecanduan

Jika pengguna dinyatakan Tidak Kecanduan, sistem tetap memberikan saran preventif seperti mempertahankan pola penggunaan saat ini, menyadari durasi *online*, dan mengoptimalkan media sosial untuk hal produktif. Hasil diagnosa kategori ini dapat dilihat pada Gambar 54.

HASIL DIAGNOSA

Ini dia hasil diagnosamu! Cek solusi awal untuk mengatasi tingkat kecanduan ini

Tidak Kecanduan

Pertahankan pola penggunaan saat ini.

Tetap sadari waktu online agar tidak bergeser ke penggunaan berlebihan.

Gunakan media sosial untuk hal produktif atau edukatif.

Gambar 54. Halaman Hasil Diagnosa Tidak Kecanduan

4.2.12 Halaman Hasil Diagnosa Mulai Berisiko

Untuk pengguna yang berada di kategori Mulai Berisiko, halaman ini menampilkan tips ringan seperti menetapkan waktu khusus untuk mengakses media sosial, menonaktifkan notifikasi, serta mengganti kebiasaan mengecek media sosial dengan aktivitas lain. Fitur seperti

“Screen Time” juga disarankan. Visualisasi ini ditunjukkan dalam Gambar 55.



Gambar 55. Halaman Hasil Diagnosa Mulai Berisiko

4.2.13 Halaman Hasil Diagnosa Kecanduan Ringan

Jika pengguna terdeteksi mengalami Kecanduan Ringan, maka sistem akan memberikan saran seperti membuat jurnal harian untuk mengenali pola penggunaan, latihan manajemen stres, hingga *social media detox* ringan dan penggunaan aplikasi pembatas waktu. halaman Hasil diagnosa untuk kategori ini ditampilkan pada Gambar 56.



Gambar 56. Halaman Hasil Diagnosa Kecanduan Ringan

4.2.14 Halaman Hasil Diagnosa Kecanduan Sedang

Pada tingkat Kecanduan Sedang, pengguna disarankan untuk berkonsultasi dengan konselor atau psikolog, membatasi akses aplikasi, menetapkan zona bebas media sosial, dan meminta dukungan sosial. Saran ini ditujukan agar pengguna dapat mulai mengendalikan kebiasaan secara lebih serius. Halaman untuk hasil diagnosa kategori ini disajikan dalam Gambar 57.



Gambar 57. Halaman Hasil Diagnosa Kecanduan Sedang

4.2.15 Halaman Hasil Diagnosa Kecanduan Berat

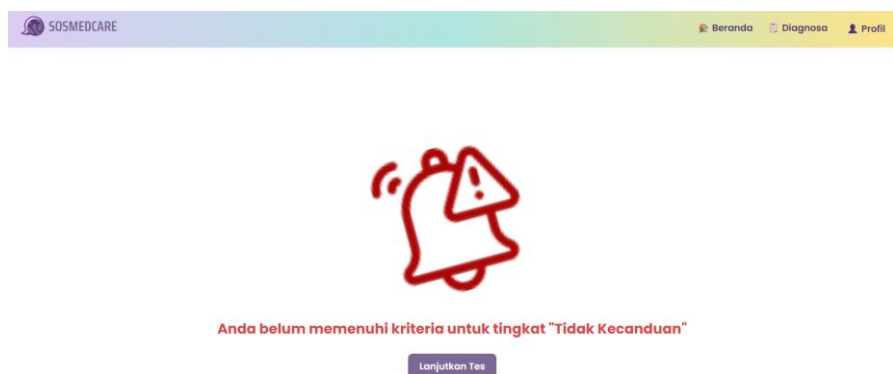
Tampilan ini muncul ketika hasil diagnosa menunjukkan bahwa pengguna berada pada tingkat Kecanduan Berat. Dalam halaman ini, sistem menyarankan solusi awal yang bersifat intervensi profesional, seperti terapi kognitif perilaku (CBT), program rehabilitasi digital, serta keterlibatan lingkungan sekitar. Rekomendasi juga mencakup penyusunan rencana penggunaan teknologi jangka panjang. Tampilan ini dapat dilihat pada Gambar 58.



Gambar 58. Halaman Hasil Diagnosa Kecanduan Berat

4.2.16 Halaman Hasil Diagnosa Tidak Termasuk “Tidak Kecanduan”

Jika hasil tidak masuk dalam kategori “Tidak Kecanduan”, halaman ini akan muncul untuk memperingatkan pengguna dan meminta mereka melanjutkan tes. Tampilan ini mencerminkan sistem pendukung untuk proses diagnosa bertahap. Halaman ini ditampilkan pada Gambar 59.

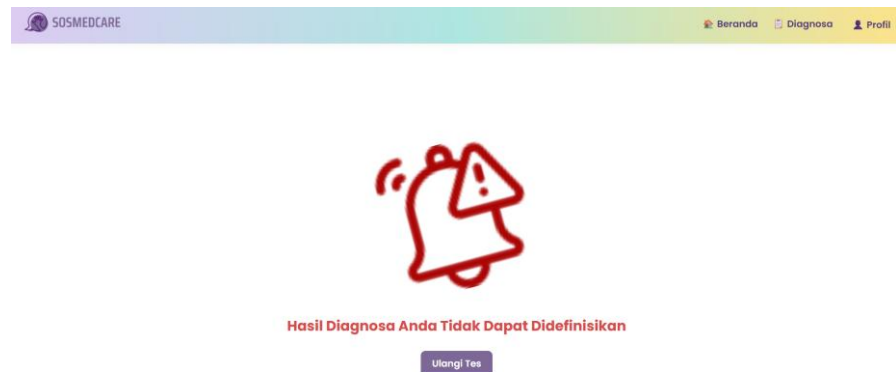


Gambar 59. Halaman Hasil Diagnosa Tidak Termasuk “Tidak Kecanduan”

4.2.17 Halaman Hasil Diagnosa Tidak Dapat Didefinisikan

Apabila sistem tidak dapat menyimpulkan hasil berdasarkan jawaban pengguna, maka akan muncul tampilan ini yang berisi peringatan

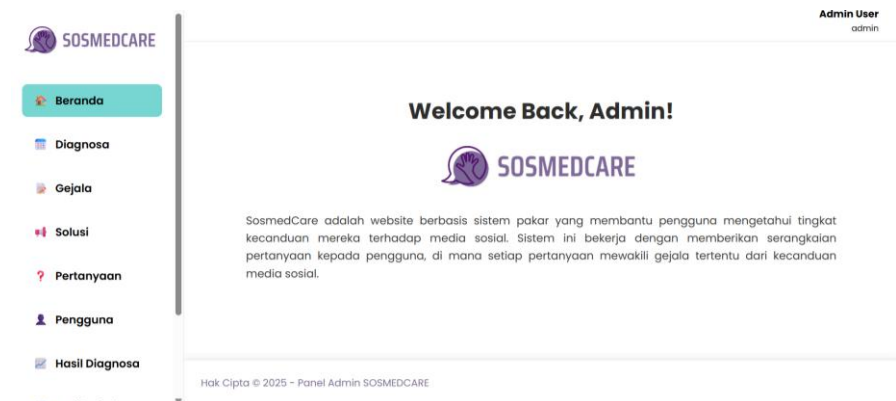
bahwa hasil diagnosa tidak dapat didefinisikan dan pengguna diarahkan untuk mengulangi tes. Halaman ini dapat dilihat pada Gambar 60.



Gambar 60. Halaman Hasil Diagnosa Tidak Dapat Didefinisikan

4.2.18 Halaman Beranda Admin

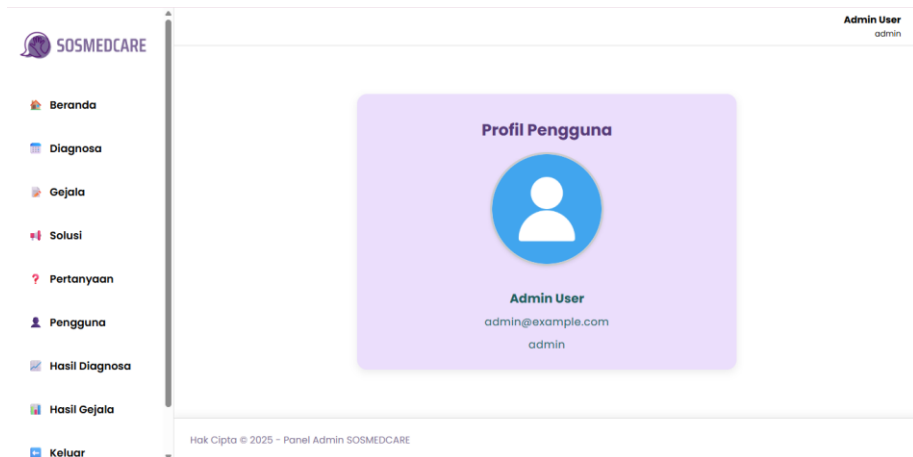
Halaman ini menjadi tampilan utama yang pertama kali dilihat saat user Pakar setelah login. Terdapat welcome back admin dan logo sistem beserta penjelasan terkait sistem. Halaman ini dapat dilihat pada Gambar 61.



Gambar 61. Halaman Beranda Admin

4.2.19 Halaman Profil Admin

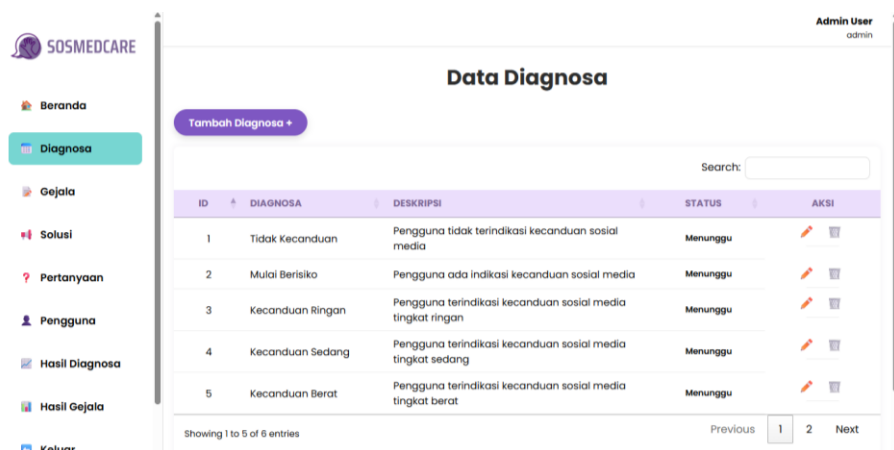
Halaman ini menyajikan informasi pribadi admin mencakup nama lengkap, alamat email dan *role*. Halaman profil ini digambarkan dalam Gambar 62.



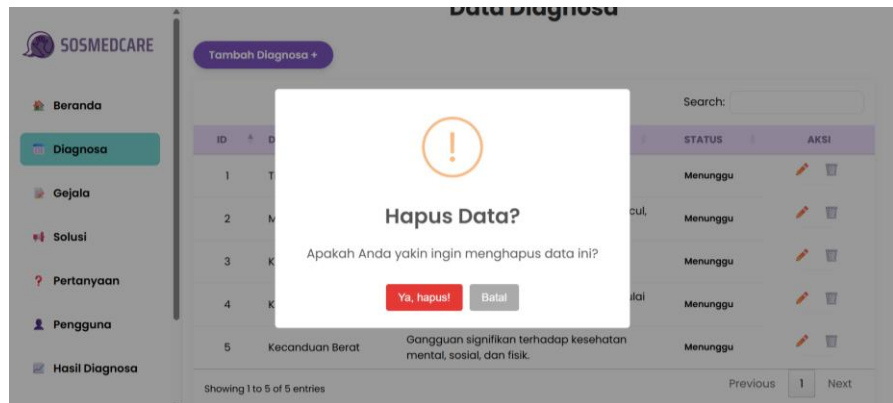
Gambar 62. Halaman Profil Admin

4.2.20 Halaman Data Diagnosa Admin

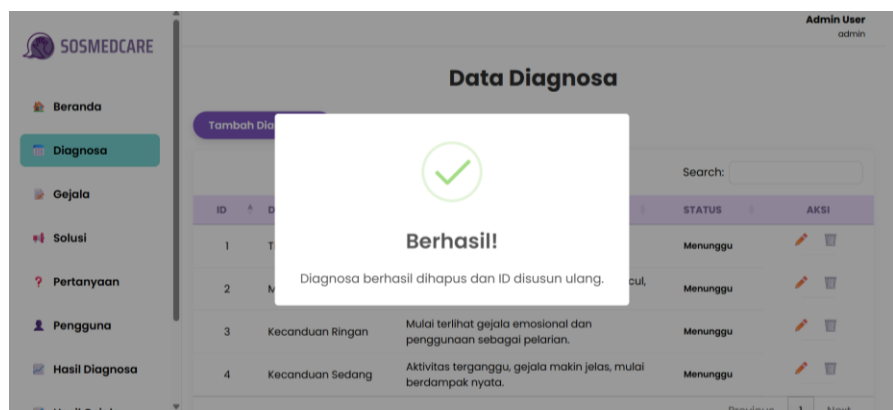
Halaman ini menampilkan daftar diagnosa yang digunakan dalam sistem pakar, lengkap dengan ID, nama diagnosa, status verifikasi, serta aksi edit dan hapus. Admin dapat menambahkan gejala baru melalui tombol "Tambah Gejala" di bagian atas. Antarmuka ini tergambarkan pada Gambar 63, Gambar 64, dan Gambar 65.



Gambar 63. Halaman Data Diagnosa Admin



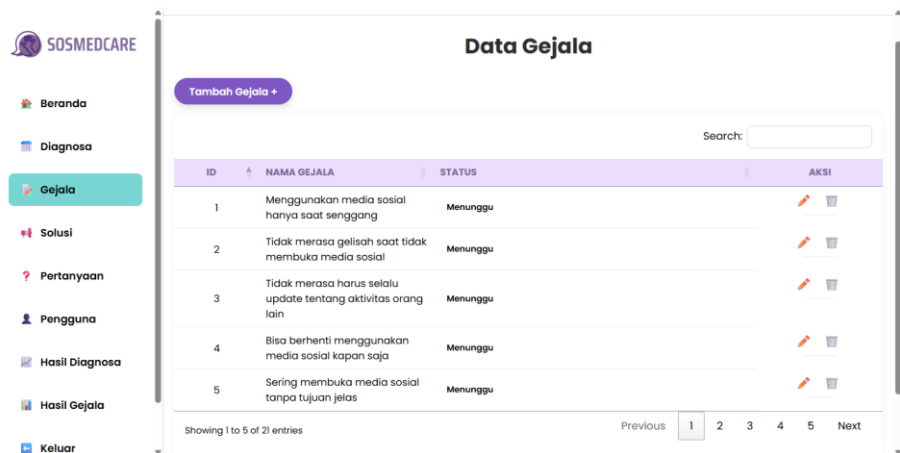
Gambar 64. Pop Up Hapus Data Diagnosa pada Admin



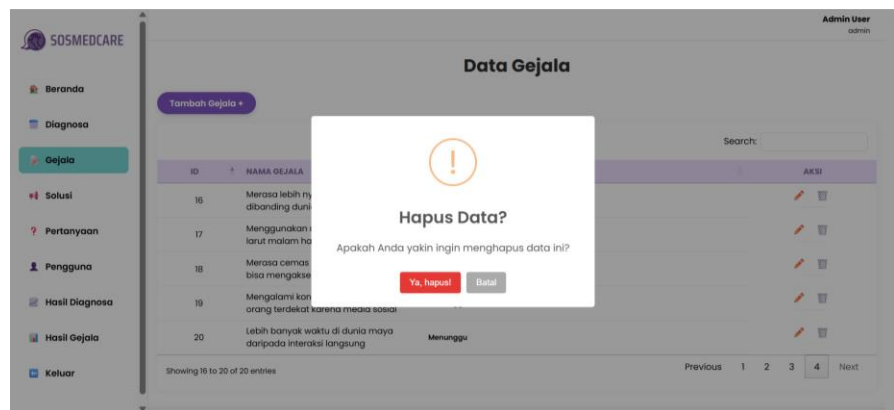
Gambar 65. Pop Up Data Berhasil Dihapus

4.2.21 Halaman Data Gejala

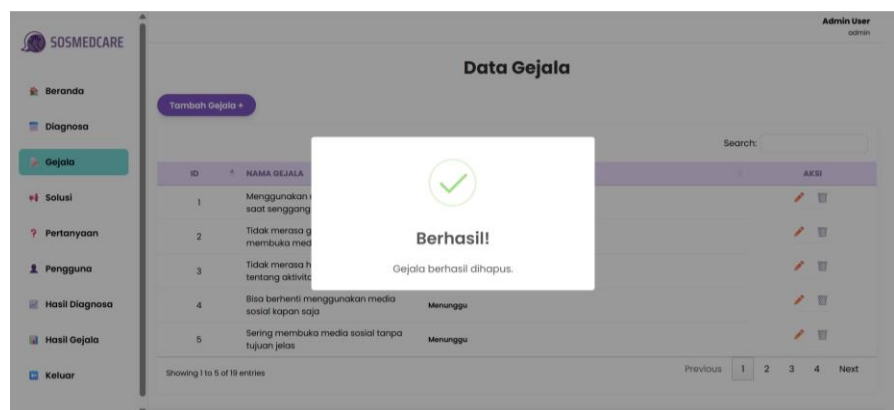
Halaman ini menampilkan daftar gejala yang digunakan dalam sistem pakar, lengkap dengan ID, nama gejala, status verifikasi, serta aksi edit dan hapus. Admin dapat menambahkan gejala baru melalui tombol "Tambah Gejala" di bagian atas. Desain ini memudahkan pengelolaan basis gejala dalam sistem. Antarmuka ini tergambarkan pada Gambar 66, Gambar 67, dan Gambar 68.



Gambar 66. Halaman Data Gejala pada Admin



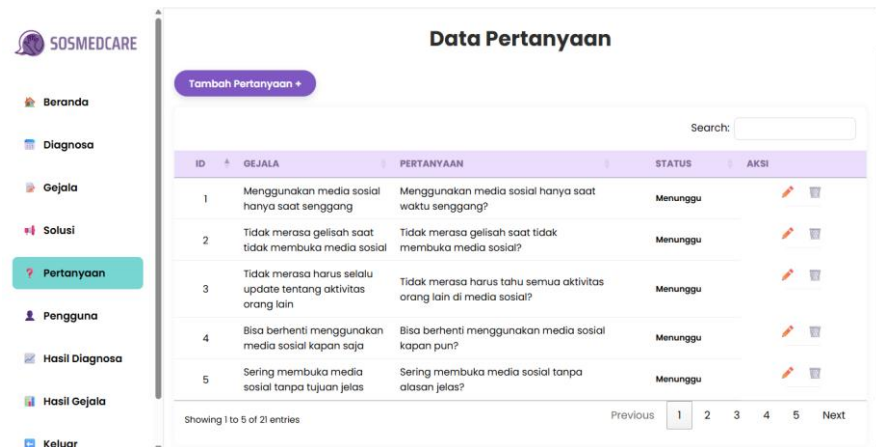
Gambar 67. Pop Up Hapus Data Gejala pada Admin



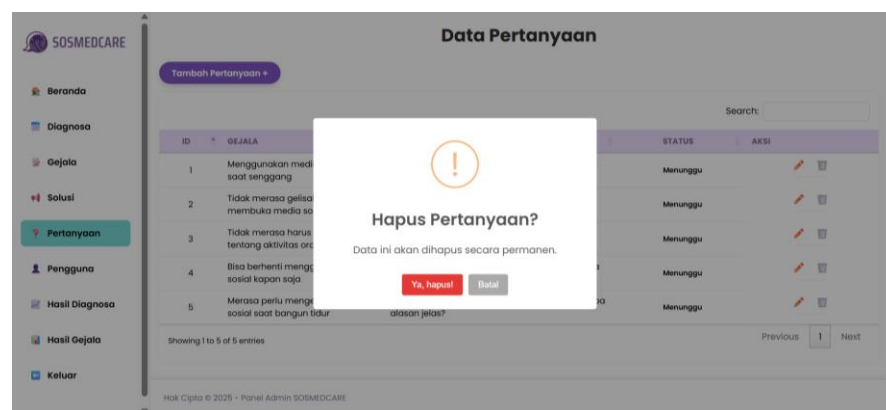
Gambar 68. Pop Up Data Gejala Berhasil Dihapus

4.2.22 Halaman Data Pertanyaan

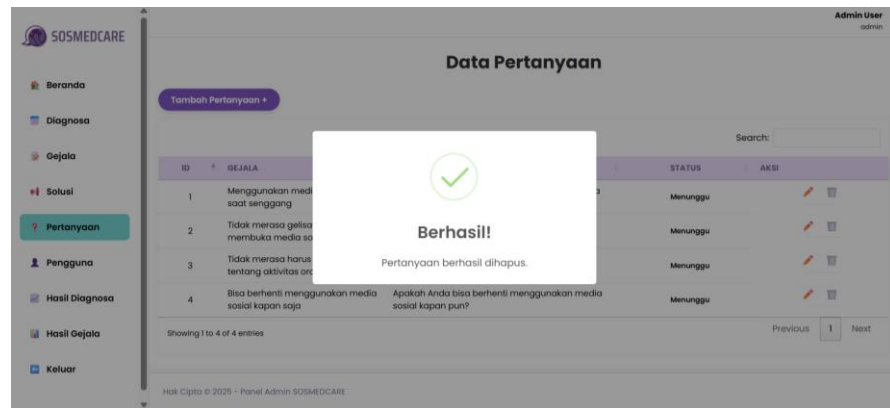
Halaman ini memuat daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam proses diagnosis, termasuk ID pertanyaan, gejala yang diwakili, isi pertanyaan, status verifikasi, dan aksi edit atau hapus. Admin dapat menambah pertanyaan baru dengan menekan tombol "Tambah Pertanyaan". Desain ini tercermin dalam Gambar 69, Gambar 70 dan Gambar 71.



Gambar 69. Data Pertanyaan pada Admin



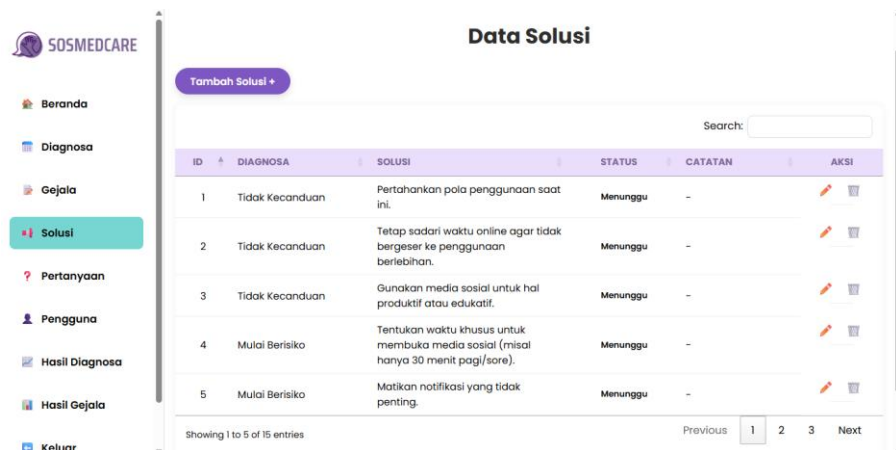
Gambar 70. *Pop Up* Hapus Data Pertanyaan pada Admin



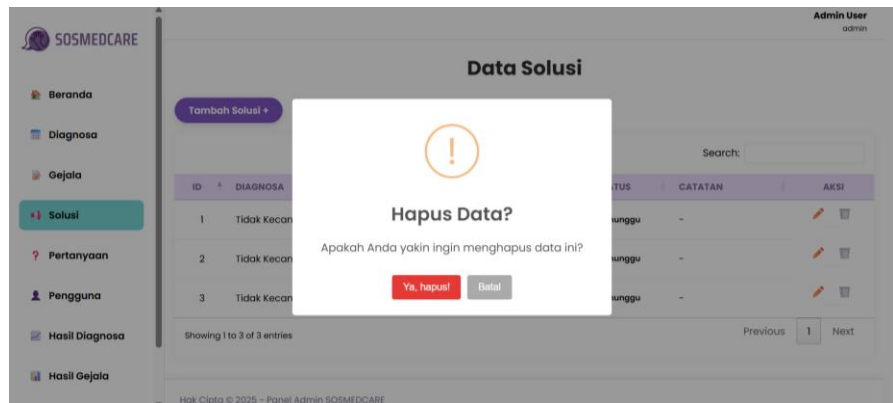
Gambar 71. *Pop Up* Data Pertanyaan Berhasil Dihapus

4.2.23 Halaman Data Solusi

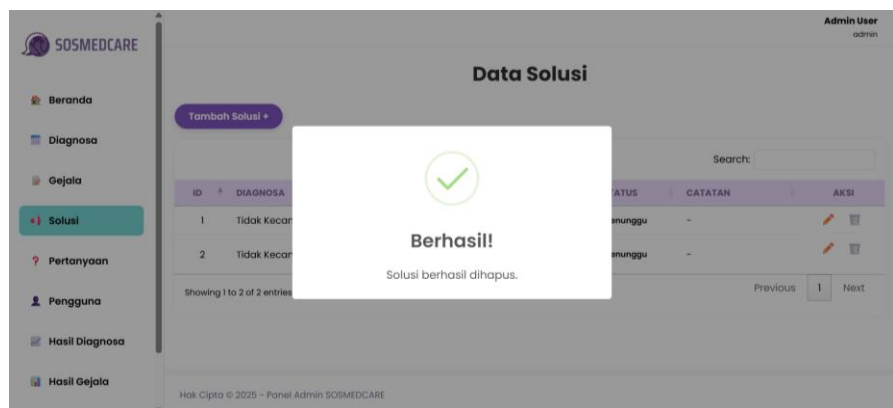
Halaman ini menampilkan solusi yang disesuaikan untuk tiap tingkat diagnosa. Setiap entri mencakup ID, nama diagnosa, isi solusi, status validasi, catatan tambahan, serta tombol edit dan hapus. Admin dapat memperbarui atau mengembangkan solusi secara berkala. Tampilan ini ditunjukkan pada Gambar 72, Gambar 73, dan Gambar 74.



Gambar 72. Data Solusi pada Admin



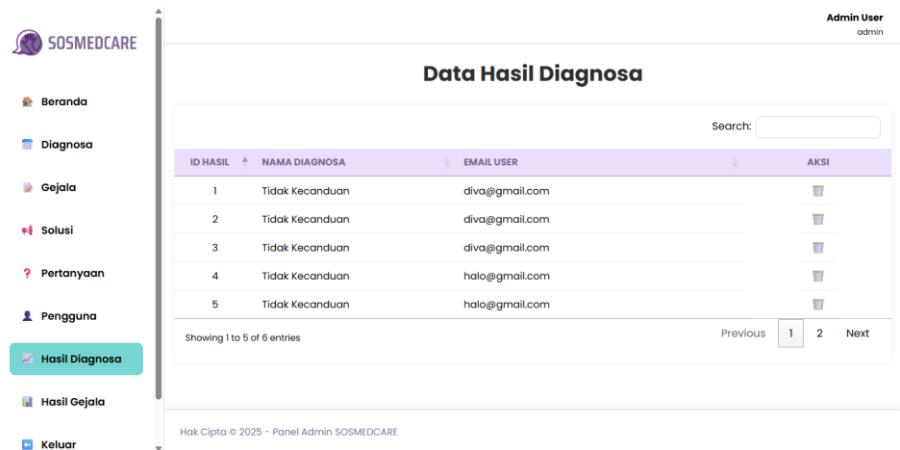
Gambar 73. *Pop Up* Hapus Data Solusi pada Admin



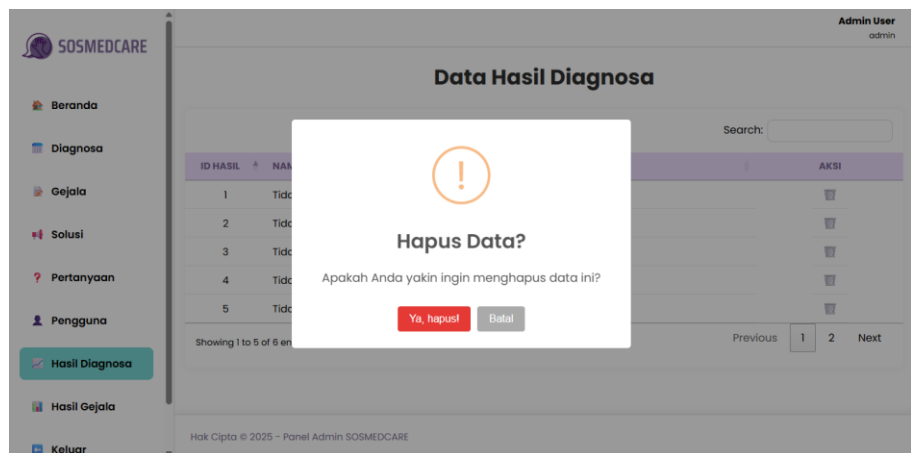
Gambar 74. *Pop Up* Data Solusi Berhasil Dihapus

4.2.24 Halaman Data Hasil Diagnosa

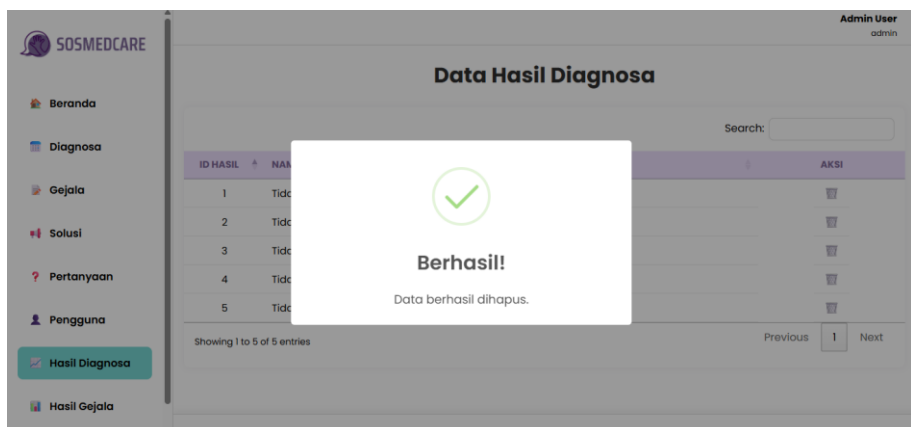
Halaman ini menyajikan hasil diagnosa pengguna yang terekam dalam sistem, termasuk ID hasil, ID diagnosa, dan ID user. Admin dapat melihat atau menghapus entri hasil diagnosa untuk keperluan pemantauan. Tampilan ini diperlihatkan pada Gambar 75, Gambar 76, dan Gambar 77.



Gambar 75. Data Hasil Diagnosa



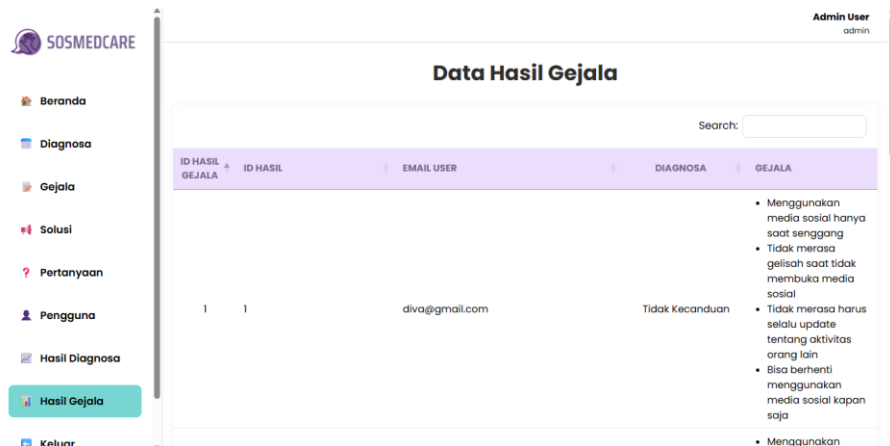
Gambar 76. Pop Up Hapus Data Hasil Diagnosa pada Admin



Gambar 77. Pop Up Data Hasil Diagnosa Berhasil Dihapus

4.2.25 Halaman Data Hasil Gejala

Halaman ini memperlihatkan relasi antara gejala dan hasil yang telah dimasukkan oleh pengguna. Admin dapat meninjau dan menghapus hasil gejala berdasarkan ID masing-masing. Tampilan halaman ini ditunjukkan dalam Gambar 78.

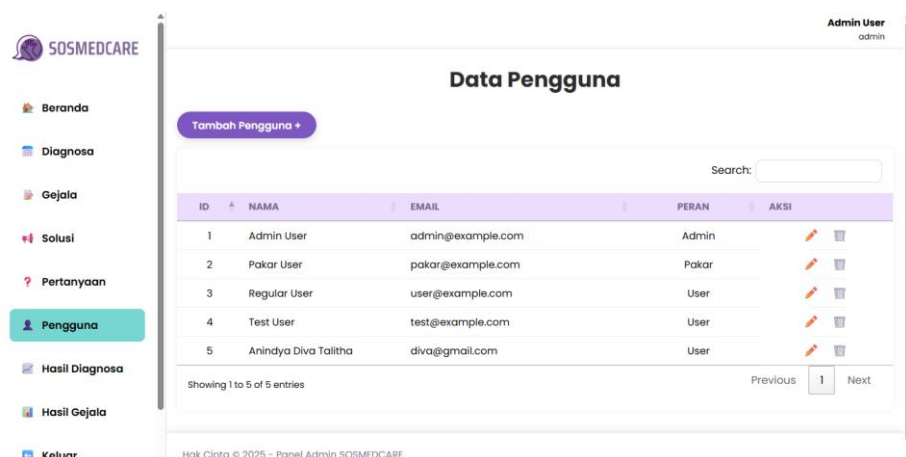


ID HASIL GEJALA	ID HASIL	EMAIL USER	DIAGNOSA	GEJALA
1	1	diva@gmail.com	Tidak kecanduan	- Menggunakan media sosial hanya saat senggang - Tidak merasa gelisah saat tidak membuka media sosial - Tidak merasa harus selalu update tentang aktivitas orang lain - Bisa berhenti menggunakan media sosial kapan saja - Menggunakan

Gambar 78. Data Hasil Gejala

4.2.26 Halaman Data Pengguna

Halaman ini menampilkan daftar semua pengguna sistem beserta ID, nama, email, peran (user, admin atau pakar), serta aksi pengeditan. Admin memiliki kemampuan untuk menambah, mengubah, atau menghapus pengguna. Tampilan halaman ini ada pada Gambar 79, Gambar 80, dan Gambar 81.



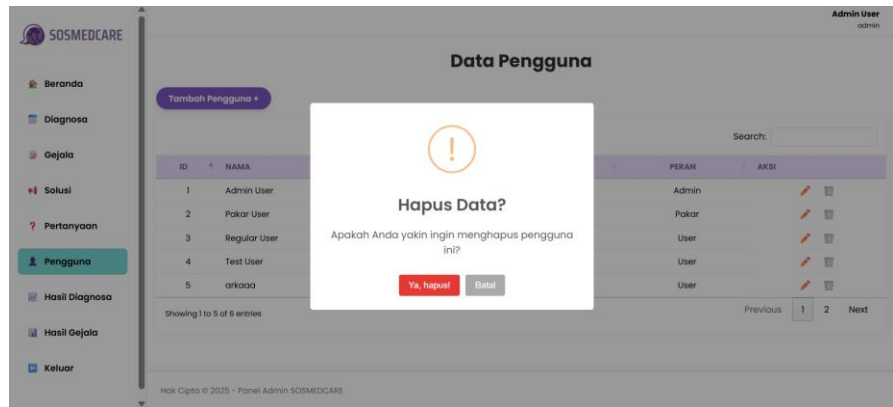
ID	NAMA	EMAIL	PERAN	AKSI
1	Admin User	admin@example.com	Admin	 
2	Pakar User	pakar@example.com	Pakar	 
3	Regular User	user@example.com	User	 
4	Test User	test@example.com	User	 
5	Anindya Diva Talitha	diva@gmail.com	User	 

Showing 1 to 5 of 5 entries

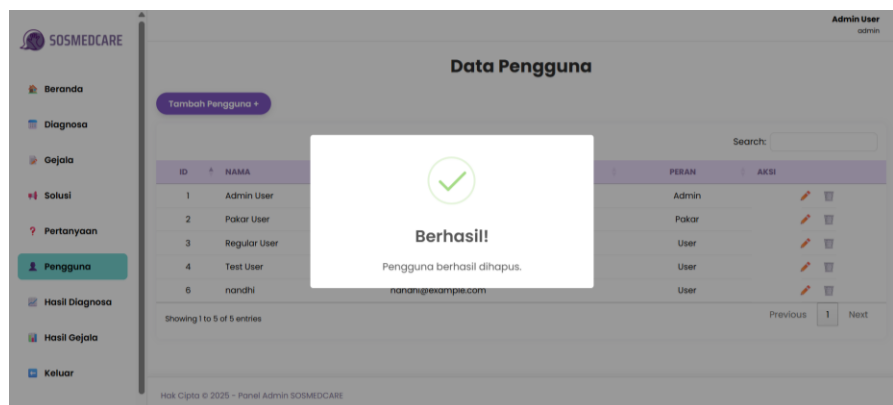
Previous 1 Next

Hak Cipta © 2025 - Panel Admin SOSMEDCARE

Gambar 79. Data Pengguna pada Admin



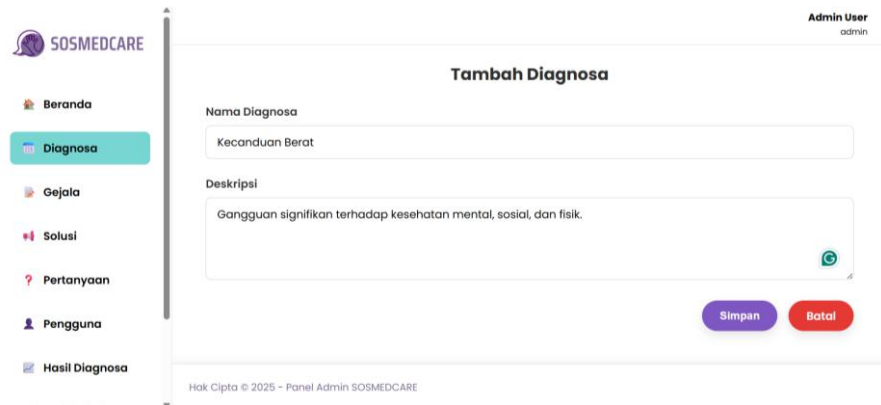
Gambar 80. Pop Up Hapus Data Pengguna pada Admin



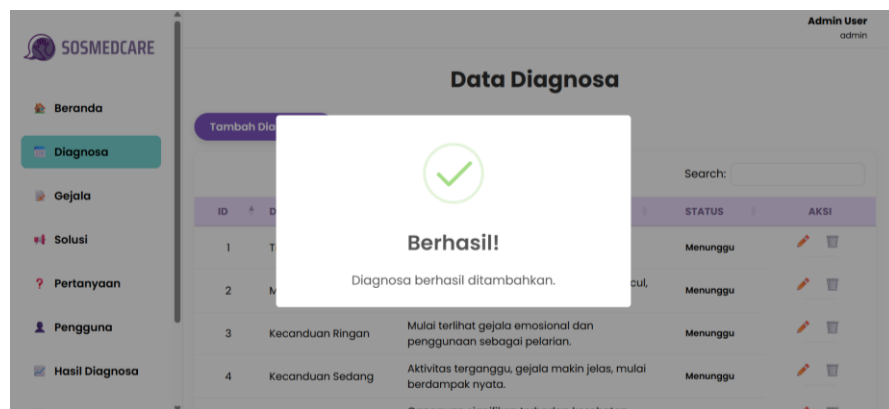
Gambar 81. Pop Up Data Pengguna Berhasil Dihapus

4.2.27 Halaman Tambah Diagnosa

Halaman ini memungkinkan admin untuk menambahkan data diagnosa baru. Admin dapat mengisi nama diagnosa dan deskripsi terkait, lalu menyimpannya ke dalam sistem. Tersedia tombol "Simpan" dan "Batal" di bagian bawah form untuk mengelola aksi penyimpanan data. Halaman ini ditunjukkan pada Gambar 82 dan Gambar 83.



Gambar 82. Halaman Tambah Diagnosa



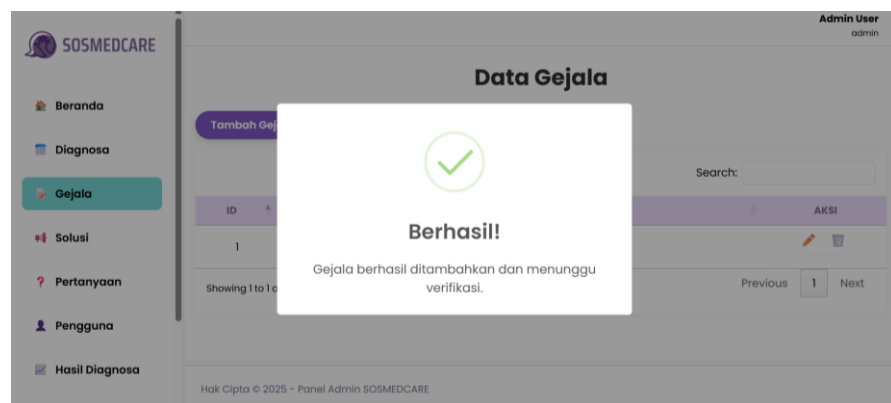
Gambar 83. Pop Up Data Diagnosa Berhasil Ditambahkan

4.2.28 Halaman Tambah Gejala

Halaman ini digunakan oleh admin untuk menambahkan gejala baru yang berhubungan dengan perilaku penggunaan media sosial. Admin cukup mengisi kolom “Nama Gejala” dan menekan tombol “Simpan” atau “Batal” untuk membatalkan proses. Halaman ini ditunjukkan pada Gambar 84 dan Gambar 85.



Gambar 84. Halaman Tambah Gejala



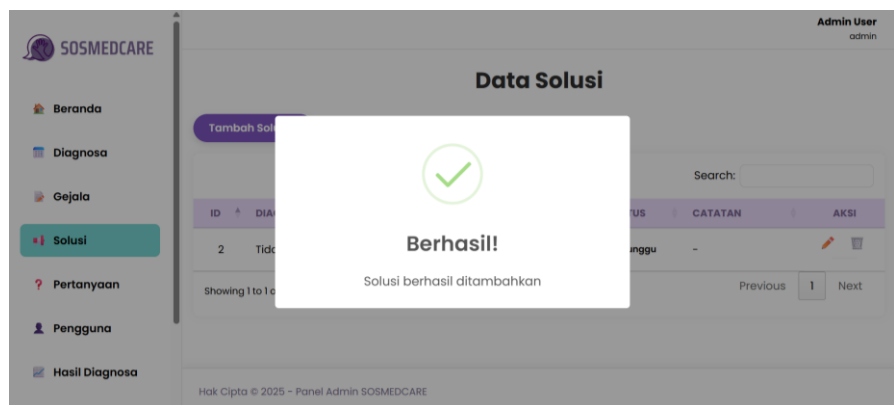
Gambar 85. *Pop Up* Data Gejala Berhasil Ditambahkan

4.2.29 Halaman Tambah Solusi

Halaman ini ditujukan untuk menambahkan solusi berdasarkan jenis diagnosa. Admin memilih diagnosa terkait dan menuliskan solusi yang relevan. Ini akan membantu pengguna mendapatkan panduan setelah proses diagnosa. Halaman ini ditunjukkan pada Gambar 86 dan Gambar 87.



Gambar 86. Halaman Tambah Solusi



Gambar 87. *Pop Up* Data Solusi Berhasil Ditambahkan

4.2.30 Halaman Tambah Pertanyaan

Digunakan untuk menambahkan pertanyaan baru yang akan dikaitkan dengan salah satu gejala. Admin dapat memilih gejala terkait dan mengisi kolom pertanyaan, lalu menyimpannya. Halaman ini tergambar pada Gambar 88 dan Gambar 89.

Gambar 88. Halaman Tambah Pertanyaan

Gambar 89. *Pop Up* Data Pertanyaan Berhasil Ditambahkan

4.2.31 Halaman Tambah Pengguna

Halaman ini memungkinkan admin untuk menambahkan pengguna baru ke sistem dengan mengisi form seperti nama, email, password, dan memilih peran (*role*) apakah sebagai admin atau pakar. Setelah diisi, data dapat disimpan melalui tombol "Simpan". Ini dapat dilihat pada Gambar 90 dan Gambar 91.

SOSMEDCARE Admin User admin

Tambah Pengguna

Nama:

Email:

Password:

Role:

Hak Cipta © 2025 - Panel Admin SOSMEDCARE

Gambar 90. Halaman Tambah Pengguna

SOSMEDCARE Admin User admin

Data Pengguna

[Tambah Pengguna +](#)

Search:

ID	NAMA	PERAN	AKSI
1	Admin User	Admin	
2	Pakar User	Pakar	
3	Regular User	User	
4	Test User	User	
5	nandhi	User	

Showing 1 to 5 of 6 entries

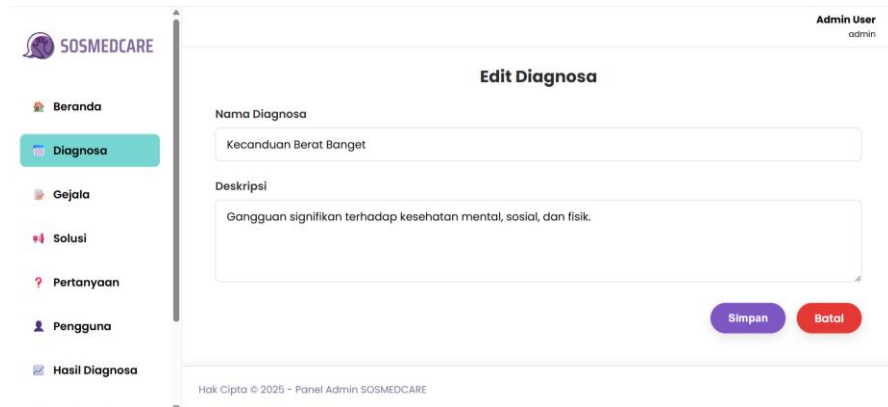
Previous **1** 2 Next

Hak Cipta © 2025 - Panel Admin SOSMEDCARE

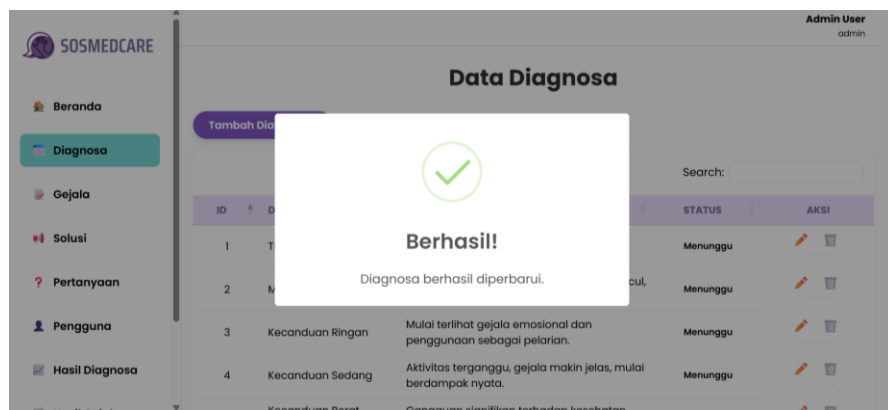
Gambar 91. *Pop Up* Data Pengguna Berhasil Ditambahkan

4.2.32 Halaman Edit Diagnosa

Halaman ini digunakan untuk mengedit data diagnosa. Admin dapat memperbarui nama diagnosa serta deskripsi yang menjelaskan tingkat kecanduan media sosial. Perubahan dapat disimpan atau dibatalkan. Halaman ini ditunjukkan pada Gambar 92 dan Gambar 93.



Gambar 92. Halaman Edit Diagnosa



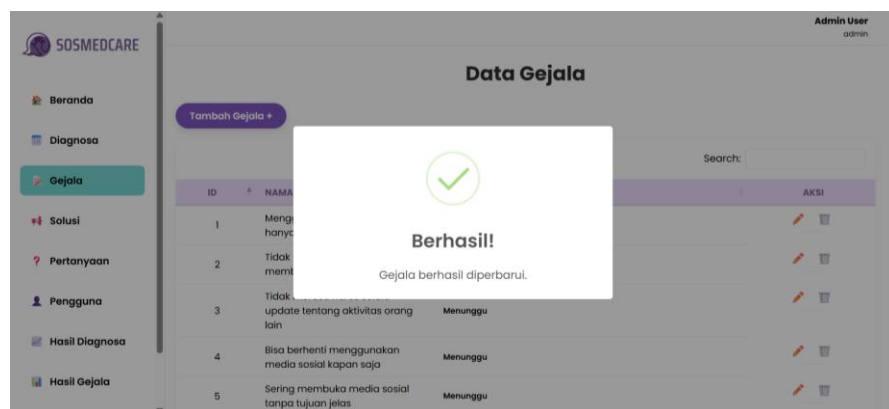
Gambar 93. *Pop Up* Data Diagnosa Berhasil Diedit

4.2.33 Halaman Edit Gejala

Halaman ini digunakan oleh admin untuk memperbarui data gejala yang sudah ada di sistem. Terdapat kolom isian "Nama Gejala" yang bisa diubah sesuai kebutuhan, dan dua tombol aksi yaitu "Simpan" untuk menyimpan perubahan serta "Batal" untuk membatalkan proses. Tampilan ini ditunjukkan pada Gambar 94 dan Gambar 95.



Gambar 94. Halaman Edit Gejala



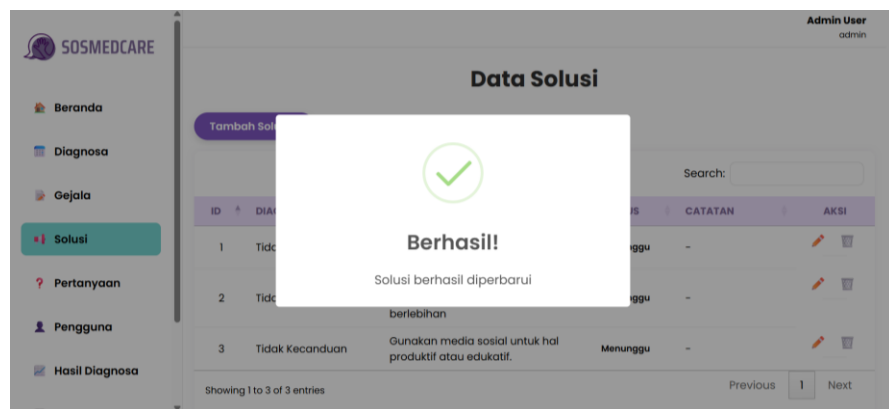
Gambar 95. Pop Up Data Gejala Berhasil Diedit

4.2.34 Halaman Edit Solusi

Pada halaman ini, admin dapat mengubah solusi yang diberikan untuk masing-masing diagnosa. Admin memilih diagnosa yang relevan, kemudian mengedit isi solusi sesuai saran atau kebijakan. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada Gambar 96 dan Gambar 97.



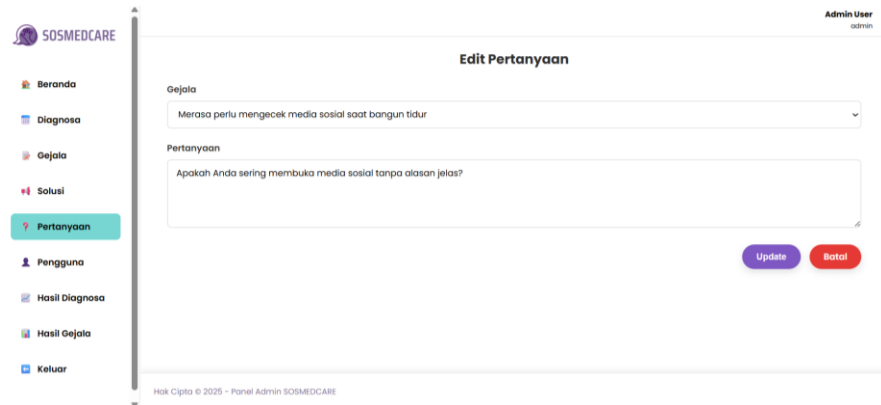
Gambar 96. Halaman Edit Solusi



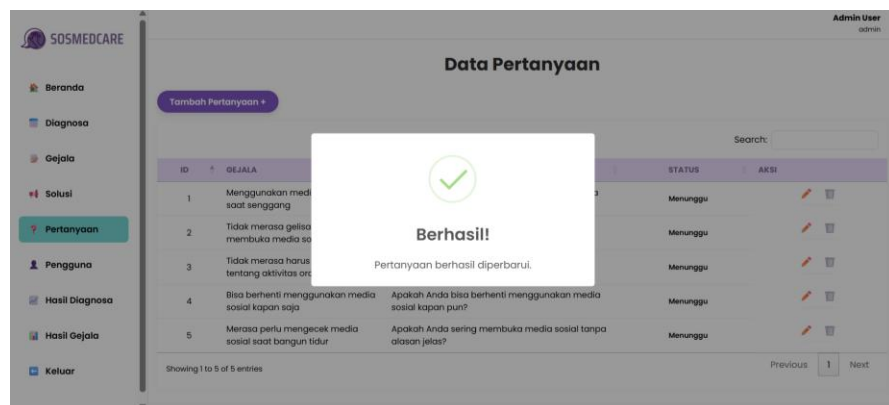
Gambar 97. Pop Up Data Solusi Berhasil Diedit

4.2.35 Halaman Edit Pertanyaan

Halaman ini digunakan oleh admin untuk mengubah isi pertanyaan yang sudah tersimpan di dalam sistem. Admin dapat memilih kembali gejala yang relevan melalui dropdown, lalu mengedit isi pertanyaannya di kolom teks yang tersedia. Dengan fitur ini, kesalahan input sebelumnya bisa diperbaiki atau penyesuaian bisa dilakukan agar pertanyaan lebih tepat sasaran. Tombol “Simpan” akan memperbarui data, sementara tombol “Batal” membatalkan proses pengeditan. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada Gambar 98 dan Gambar 99.



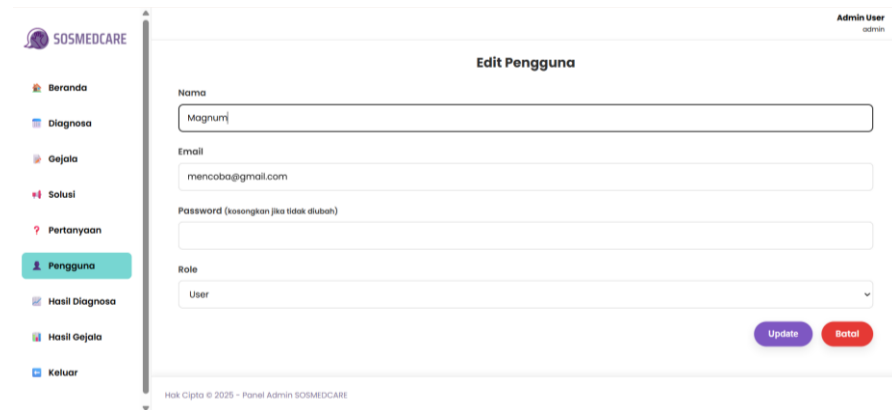
Gambar 98. Halaman Edit Pertanyaan



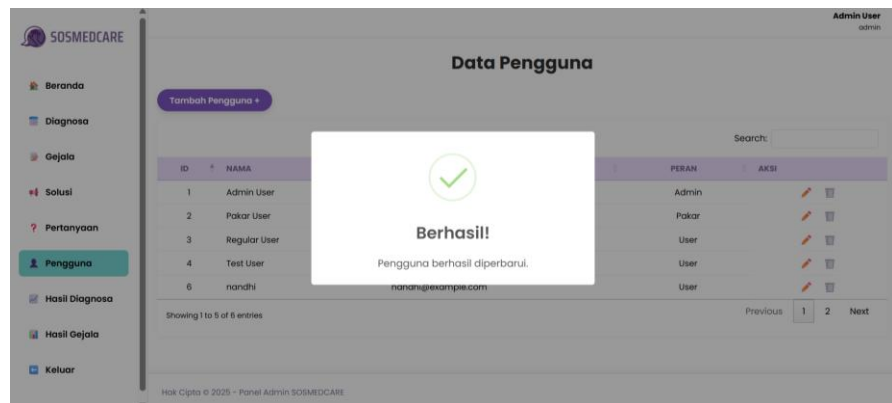
Gambar 99. Pop Up Data Pertanyaan Berhasil Diedit

4.2.36 Halaman Edit Pengguna

Halaman ini ditujukan untuk memperbarui data pengguna yang sudah terdaftar. Formulirnya berisi informasi nama, email, password, dan peran pengguna yang bisa diedit, lalu disimpan melalui tombol yang tersedia. Tampilan halaman ini diperlihatkan pada Gambar 100 dan Gambar 101.



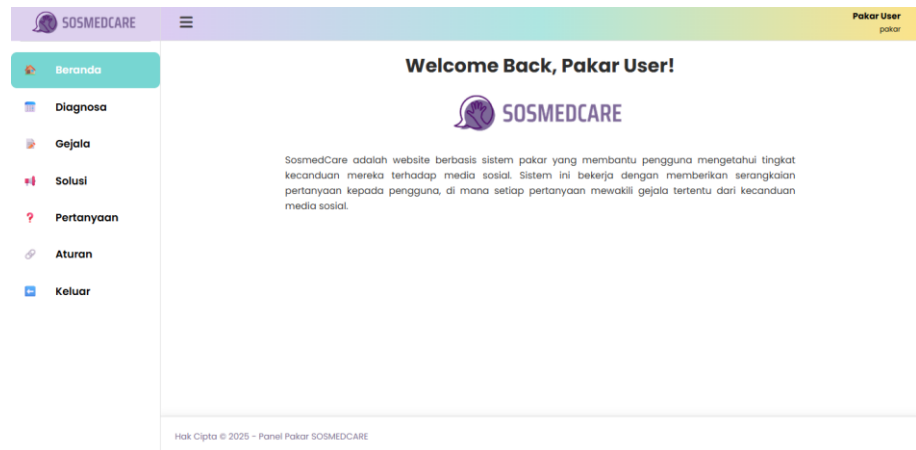
Gambar 100. Halaman Edit Pengguna



Gambar 101. *Pop Up* Data Pengguna Berhasil Diedit

4.2.37 Halaman Beranda Pakar

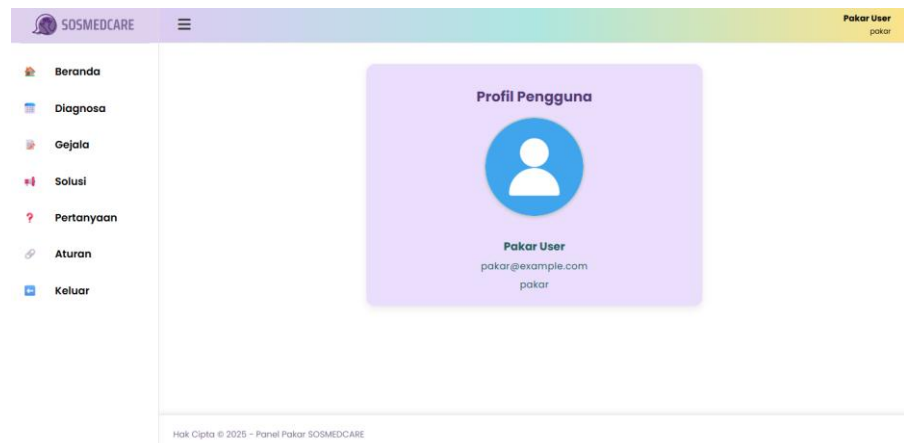
Halaman beranda merupakan tampilan utama setelah pakar berhasil login ke sistem. Halaman ini menampilkan ucapan sambutan kepada pengguna yang login dengan nama mereka serta deskripsi singkat tentang tujuan sistem SosmedCare sebagai sistem pakar yang digunakan untuk mendeteksi tingkat kecanduan media sosial melalui serangkaian pertanyaan. Tampilan halaman ini diperlihatkan pada Gambar 102.



Gambar 102. Halaman Beranda Pakar

4.2.38 Halaman Profil Pakar

Halaman ini menampilkan informasi personal dari pakar yang login ke dalam sistem. Data yang ditampilkan meliputi nama lengkap, email, jenis kelamin, dan umur. Tampilan ini membantu pakar mengenali identitasnya di dalam sistem. Tampilan halaman ini diperlihatkan pada gambar nomor 103.

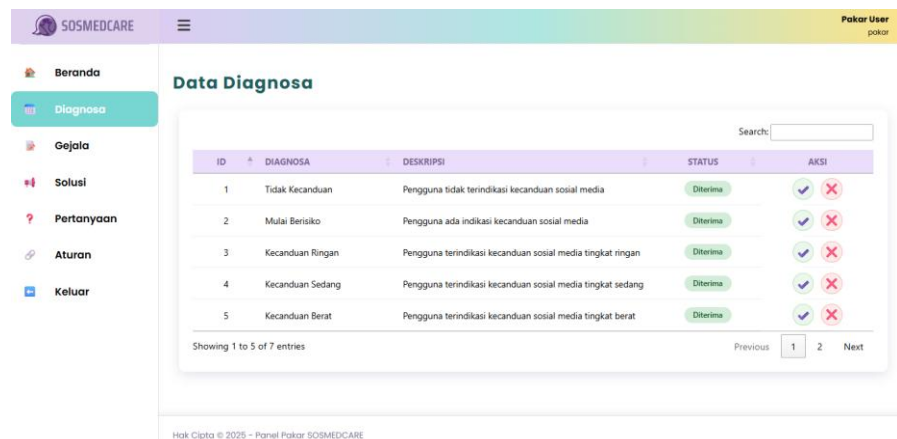


Gambar 103. Halaman Profil Pakar

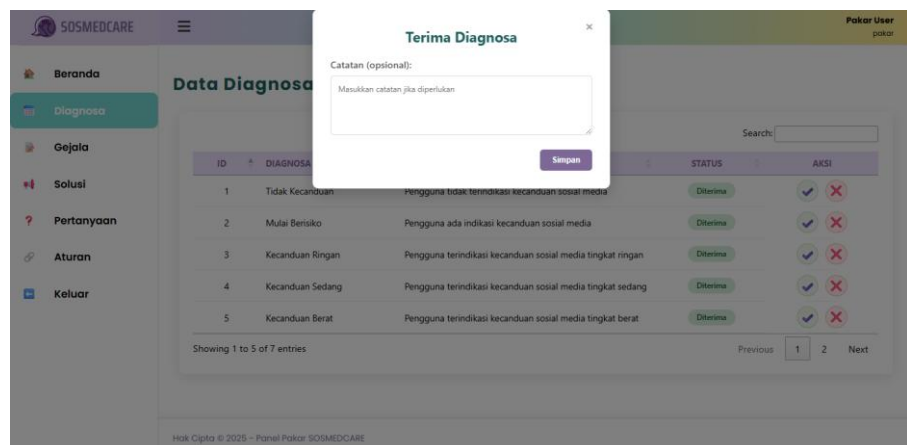
4.2.39 Halaman Verifikasi Data Diagnosa

Halaman ini menampilkan daftar diagnosa tingkat kecanduan beserta deskripsi, status validasi, dan tombol aksi validasi atau penolakan

oleh pakar. Tabel ini menjadi pusat peninjauan diagnosa yang diajukan oleh admin sebelum digunakan dalam sistem. Tampilan halaman ini diperlihatkan pada Gambar 104 dan Gambar 105



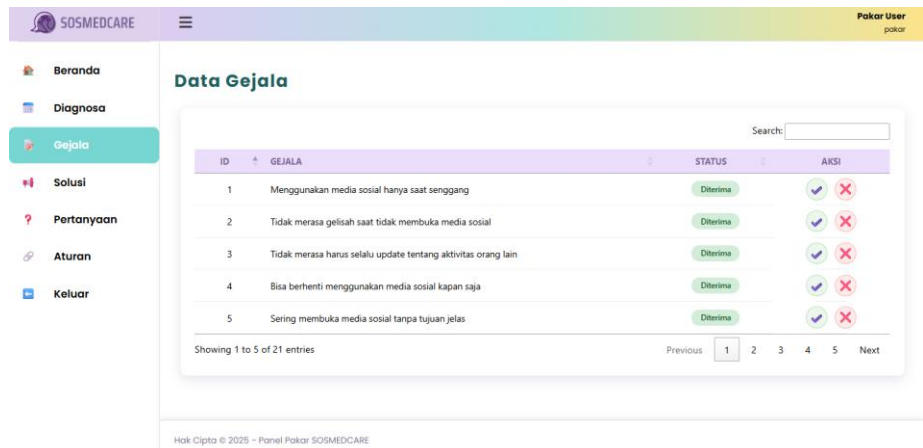
Gambar 104. Halaman Verifikasi Data Diagnosa



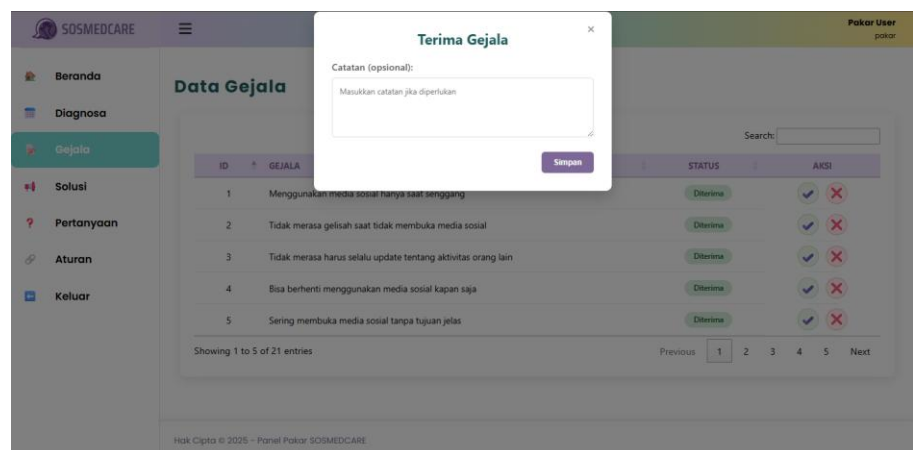
Gambar 105. *Pop up* Verifikasi Data Diagnosa

4.2.40 Halaman Verifikasi Data Gejala

Halaman ini memperlihatkan daftar gejala kecanduan yang diajukan oleh admin. Pakar dapat melakukan verifikasi melalui tombol aksi (centang untuk validasi, silang untuk penolakan). Data yang telah diverifikasi akan digunakan dalam proses diagnosis kecanduan pengguna. Tampilan halaman ini diperlihatkan pada Gambar 106 dan Gambar 107.



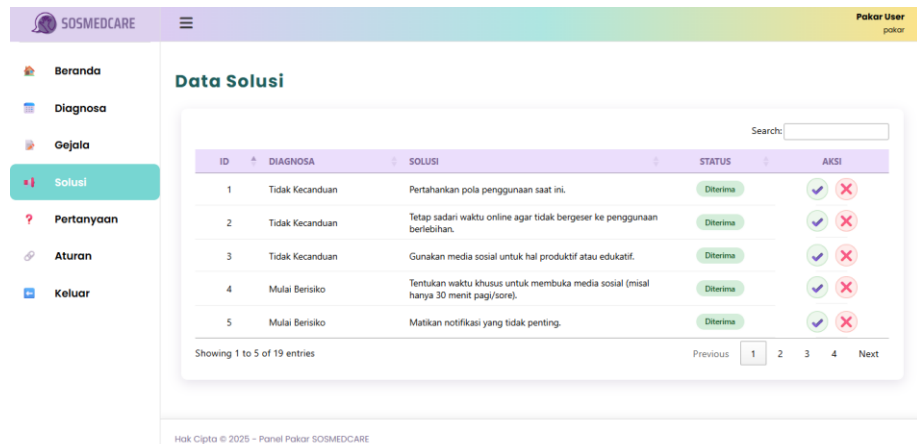
Gambar 106. Halaman Verifikasi Data Gejala



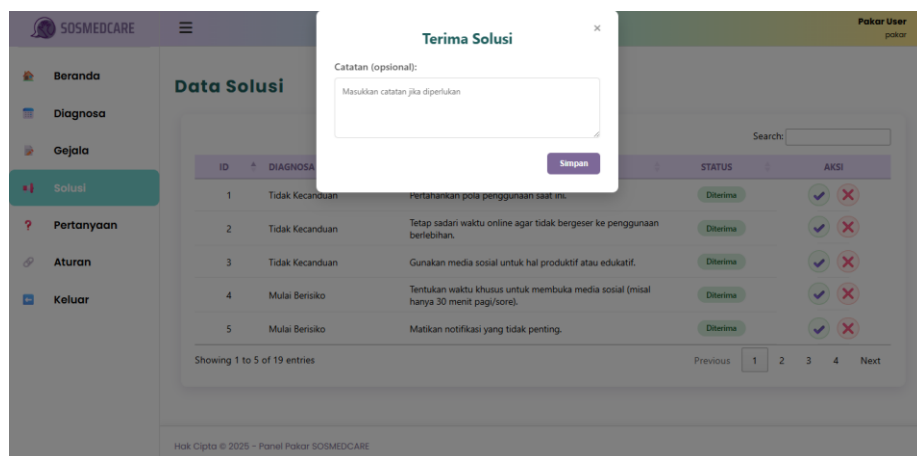
Gambar 107. *Pop up* Verifikasi Data Gejala

4.2.41 Halaman Verifikasi Data Solusi

Halaman ini menampilkan daftar solusi yang dikaitkan dengan diagnosa tertentu. Pakar dapat memvalidasi atau menolak solusi yang diajukan berdasarkan kesesuaian konten dengan kondisi diagnosa. Tampilan halaman ini diperlihatkan pada Gambar 108 dan Gambar 109.



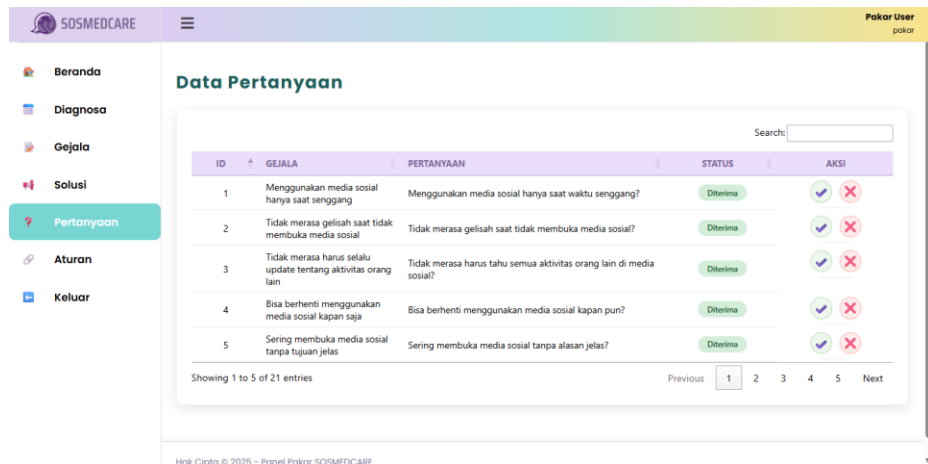
Gambar 108. Halaman Verifikasi Data Solusi



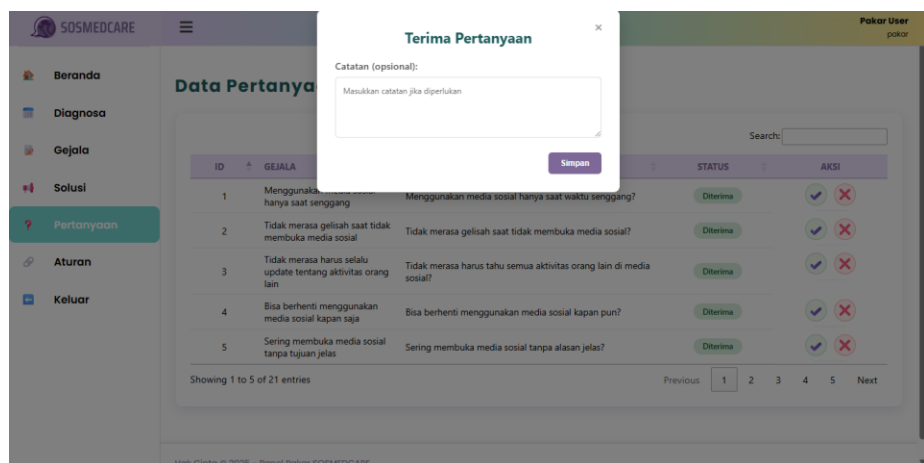
Gambar 109. Pop Up Verifikasi Data Solusi

4.2.42 Halaman Verifikasi Data Pertanyaan

Halaman ini digunakan oleh pakar untuk meninjau dan memverifikasi daftar pertanyaan yang dikaitkan dengan gejala-gejala kecanduan. Setiap pertanyaan ditampilkan bersama dengan ID gejala terkait, status verifikasi, dan opsi validasi/penolakan. Tampilan halaman ini diperlihatkan pada Gambar 110 dan Gambar 111.



Gambar 110. Halaman Verifikasi Data Pertanyaan



Gambar 111. Halaman Verifikasi Data Pertanyaan

4.2.43 Halaman Manajemen Data Aturan Diagnosa

Halaman ini digunakan oleh pakar untuk meninjau dan memverifikasi daftar pertanyaan yang dikaitkan dengan gejala-gejala kecanduan. Setiap pertanyaan ditampilkan bersama dengan ID gejala terkait, status verifikasi, dan opsi validasi/penolakan. Tampilan halaman ini diperlihatkan pada Gambar 112 dan Gambar 113.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem pakar untuk mendiagnosa tingkat kecanduan media sosial, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Sistem pakar yang dikembangkan berhasil mengidentifikasi lima tingkat kecanduan media sosial secara sistematis, yaitu Tidak Kecanduan, Mulai Berisiko, Kecanduan Ringan, Kecanduan Sedang, dan Kecanduan Berat.
- 2) Metode inferensi *backward chaining* terbukti efektif dalam menganalisis data gejala yang diberikan oleh pengguna untuk menarik kesimpulan akhir secara logis dan terstruktur, menyerupai cara berpikir seorang pakar.
- 3) Implementasi sistem berbasis web dengan *framework* Laravel memberikan kemudahan akses, baik untuk pengguna umum, admin, maupun pakar, serta mendukung pengelolaan data yang efisien.
- 4) Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat diagnosis, tetapi juga sebagai media edukasi dengan menyediakan rekomendasi solutif yang disesuaikan dengan tingkat kecanduan pengguna.
- 5) Dengan pendekatan yang interaktif dan responsif, sistem ini dapat menjadi alternatif konsultasi awal yang praktis, terutama bagi pengguna yang belum memiliki akses ke layanan profesional.

5.2 Saran

Agar sistem ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- 1) Integrasi dengan media sosial atau perangkat digital untuk pemantauan otomatis aktivitas pengguna, sehingga diagnosis dapat dilakukan lebih akurat secara *real-time*.
- 2) Penambahan fitur *tracking* dan evaluasi berkala, seperti grafik penggunaan media sosial mingguan atau pengingat waktu layar, agar pengguna dapat memantau progres mereka.

- 3) Kolaborasi dengan tenaga profesional (psikolog/psikiater) untuk validasi lebih lanjut terhadap konten gejala dan solusi yang ditawarkan sistem.
- 4) Pengembangan aplikasi mobile agar sistem dapat menjangkau lebih banyak pengguna dan memudahkan akses di mana saja.
- 5) Penelitian lebih lanjut dan uji coba sistem pada pengguna yang lebih luas untuk mengevaluasi efektivitas sistem dalam kehidupan nyata dan menyempurnakan akurasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2017). Social Networking Sites and Addiction: Ten Lessons Learned. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(3), 311. <https://doi.org/10.3390/ijerph14030311>
- Wiyono, R. A., Mulyani, E. D. S., Saputra, R. D., & Mulya, D. S. (2022). Aplikasi Sistem Pakar Diagnosis Kecanduan Media Sosial Berbasis Android Menggunakan Metode Forward Chaining Dan Certainty Factor. *Seminar Nasional Corisindo*, 527–531. <https://corisindo.stikom-bali.ac.id/penelitian/index.php/semnas/article/view/109>
- Ariani, A. F., Huzaeni, & Hendrawaty. (2023). Sistem Pakar Diagnosa Tingkat Kecanduan Sosial Media pada Mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe dengan Menggunakan Metode Dempster Shafer. *Jurnal Teknologi Rekayasa Informasi dan Komputer*, 6(2), 84-89. <https://e-jurnal.pnl.ac.id/TRIK/article/download/4707/3423>
- Wulandari, D. A., & Nugroho, A. S. (2021). Penerapan Metode Backward Chaining pada Sistem Pakar dengan Teknik Depth First Search. *International Journal of Network Security*, 23(4), 51-55. <https://ijns.org/journal/index.php/ijns/article/view/1319>
- Fitriani, N. (2020). Sistem Pakar Diagnosa Gejala Kecanduan Gadget pada Remaja. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 7(1), 45-52. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/jnkti/article/view/8109/pdf>
- Dewi, N. V., Anraeni, S., & Manga, A. R. (2023). Sistem Pakar Diagnosa Gejala Kecanduan Game Online Menggunakan Metode Backward Chaining dan Certainty Factor Berbasis Web. *BUSITI: Jurnal Bisnis dan Teknologi Informasi*, 4(2). <https://doi.org/10.33096/busiti.v4i2.1666>
- Huda, N. (2023). Efektivitas Metode Backward Chaining Terhadap Peningkatan Kemampuan Memakai Kaos Oblong Murid Tunagrahita Sedang Kelas Dasar II di SLB Negeri 1 Kota Bima [Artikel]. Universitas Negeri Makassar. <https://eprints.unm.ac.id/27482/>

LAMPIRAN

Link github SOSMEDCARE

<https://github.com/MutiaNandhika/Sispak-KecanduanMedsos-BC>